

Sotsiaalkindlustusamet

**TÄISEALISE INIMESE ABI- JA TOETUSVAJADUSE HINDAMISE
JUHEND**

2025

Sisukord

1. Täisealise abivajaduse hindamise eesmärk ja alused.....	3
2. Üldised põhimõtted abi- ja toetusvajaduse või teenuse vajaduse hindamisel.....	3
3. Täisealise abivajaduse hindamisküsimustiku ülesehitus	10
1) SUHTLEMINE	10
2) VAIMNE TERVIS.....	10
3) FÜÜSILINE TERVIS	12
4) ELUKESKKOND	12
5) HÕIVATUS	13
6) VABA AEG JA HUVITEGEVUS.....	14
7) IGAPÄEVAELU TOIMINGUD.....	14
4. Kõrvaline abi, abivahendid ja eluruumi kohandamine	16
5. Inimese olulisemad vajadused	17
6. Otsustustugi abimeetme valikul.....	18
LISA 1. Abistavad küsimused.....	19
LISA 2. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni põhimõtted.....	46

1. Täisealise abivajaduse hindamise eesmärk ja alused

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) §15 kohustab kohalikku omavalitsust hindama inimese abivajadust ning sellest lähtuvalt välja selgitama inimese abivajadusele vastava abi ehk sobiva sotsiaalhoolekande abimeetme. SHS §62 ja §70 kohustavad Sotsiaalkindlustusametit hindama inimese erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust. Eelnimetatud kohustuste täitmiseks on STAR2-e loodud universaalne, struktureeritud ülesehitusega täisealise inimese abi- ja toetusvajaduse hindamise küsimustik, mis on **sotsiaalvaldkonna spetsialistide poolt ühtsetel alustel kasutatav nii kohaliku omavalitsuse kui ka riiklike (sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse) teenuste vajaduse hindamiseks.**

Täisealise inimese abivajaduse tervikliku hindamise eesmärgiks on välja selgitada, millistes eluvaldkondades ja millisel määral inimene toetust ja abi vajab, et säilitada või parandada tema elukvaliteeti ning tagada võimetekohane osalemine ja toimetulek ühiskonnas.

Hindamise käigus dokumenteeritakse inimese hetkeolukord ning spetsialist saab põhjaliku ülevaate valdkondadest, kus inimesel on tuge ja abi vaja. Saadud informatsioon on vajalikuks sisendiks, et langetada otsuseid, milliste tegevuste, toetuste ja teenusega on võimalik inimese elukvaliteeti säilitada või parandada. Oluline on meeles pidada, et hindamine iseenesest ei määra teenust. Spetsialist saab hindamistulemustele tuginedes teha kaalutletud otsuse.

STAR2-e loodud hindamisvahend on andmevahetuse ja andmete analüüsitavuse parandamise eesmärgil seostatud **Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooniga (RFK)¹**, mis tähendab, et hindamisvahendi alamküsimused on automaatselt seostatud klassifikaatori kindla koodiga ning abivajaja probleemi või piirangu ulatus määratakse RFK määrajate skaala alusel. **Korduvhindamisel on võimalik analüüsida ja võrrelda eelmise hindamise andmeid, kas inimesele osutatavad toetused ja/või teenused on inimese vaates olnud tulemuslikud.**

2. Üldised põhimõtted abi- ja toetusvajaduse või teenuse vajaduse hindamisel²

Spetsialist viib inimese ja/või tema lähedasega kohtudes läbi struktureeritud vestluse, toetudes seejuures iga eluvaldkonna juures välja toodud täpsustavatele küsimustele. Samas ei ole kohustuslik järgida küsimustiku täpset järjekorda. Vestluse läbiviimisel on hindajal võimalik tugineda ka Lisas 1 toodud abistavatele küsimustele. Eesmärk ei ole inimest üle kuulata, vaid koondada kokku asjasse puutuv oluline informatsioon inimese toimetuleku

¹RFK kohta loe lähemalt lisast „Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon“

² Tugineb WHODAS 2.0 küsimustiku tugiraamidil.

tagamiseks. Inimeselt ja tema lähedastelt küsitakse vaid neid andmeid, mille kohta teistest ametlikest allikatest infot ei saa.

Hindaja uurib vestluse käigus, millised piirangud inimesel igapäevaste tegevuste sooritamisel esinevad. **Piirangu all tuleb silmas pidada seda, kas tegevuse sooritamine nõuab inimeselt näiteks suuremat pingutust, tekitab ebamugavustunnet või valu, eeldab aeglasemat tegevuse sooritamist või muutust sooritamise viisis. Küsimustele vastamisel tuleb arvestada ka neid piiranguid, mis on tingitud inimese tervise seisundist** (sh haigus, vigastus, füüsilised, vaimsed ja emotsionaalsed probleemid ning sõltuvusprobleemid).

Näide 1: Kui inimene ei saa ennast ise üle kogu keha pesta reumaatilise haiguse tõttu, tuleb hinnata tegevusel ilmnevat piirangut skaalal 1-4. Kui inimene saab hakkama pesemistoiminguga, kuid ta ei saa üle keha pesta seetõttu, et tal puudub soe vesi, tuleb märkida „0 – ei ole probleemi“, sest pesemisega seotud piirangud ei ole tingitud terviseolukorrast, vaid elukeskkonnast.

Näide 2: Kui tegemist on 80-aastase inimesega, kes ei ole võimeline tööd tegema ega soovigi töötada, siis tuleb märkida “9- mittekohtaldatav”, kuna töötamisega seonduv on tingitud vanusest, mitte terviseolukorrast.

Abivajaduse hindamisel hinnatakse nõ **heade ja halbade asjaolude või heade ja halbade päevade keskmist, mõeldes viimasele 30 päevale**. Vastamisel arvestame praegust olukorda (piirangu esinemist viimasel 30 päeval). 30 päeva periood on seatud põhjendusel, et inimesed suudavad möödunud meenutada kõige selgemini just ühe kuu jooksul ning RFK põhimõte on hinnata inimese tegevusvõimet käesoleval ajahetkel ja mitte minevikus. **Vajadusel võib hindamisel aluseks võtta ka pikemat ajaperioodi**, sest inimeste tervislik seisund võib erinevatel perioodidel olla väga muutlik ja 30 päeva ei pruugi anda terviklikku pilti inimese tegelikust abivajadusest.

Kui inimene on viimasel 30 päeval kogenud **ajutisi või ühekordseid terviseprobleeme** (nt haigestus külmetushaigusesse ja on ajutiselt voodikeskne), siis see tähendab, et **tegemist on ajutise haigestumisega, mis ei ole seotud inimese valdava tervise seisundiga**. Sellisel juhul tuleb kaaluda, kas antud terviseprobleem võib mõjutada inimese tegevus- ja osalusvõimet eelduslikult ka tulevikus. Kui jah, siis tuleb seda tegevusvõime hindamisel ka arvestada. Kui see ajutine terviseprobleem eelduslikult ei kordu ja inimene paraneb, siis ärge seda tegevusvõime hindamisel arvestage (nt paluge inimesel mõelda olukorrale, mis eelnes ajutisele haigestumisele).

Hinnata tuleb seda, kuidas inimene tavaliselt hinnatavat tegevust sooritab. Eesmärk on hinnata inimese tegelikku sooritust ehk seda, kuidas inimene praegu tegevust oma tavapärasel keskkonnas teeb:

- mitte võrrelda sooritust oluliselt varasema perioodiga (välja arvatud erihooletandeteenuse vajaduse hindamisel). Näiteks 60-aastaselt on inimese piiranguteta jalgsi läbitava vahemaa pikkus märkimisväärselt lühem kui 18-aastaselt;

- kui inimene sooritab toimingut abivahendiga või koos teise inimese abiga ja see abi on selle toimingu sooritamisel alati püsivalt kättesaadav, siis võtke seda vastamisel arvesse;

Näide: Kui inimene kasutab kuuldeaparaati ning saab selle abil ilma piiranguteta suhelda, siis tuleb märkida, et suhtlemisel probleeme ei esine. Seda vaatamata asjaolule, et ilma kuuldeaparaadita ta ei kuule ja suhelda ei saa.

- kui abistaja/abivahend ei ole alati kättesaadav või inimene seda mingil põhjusel ei kasuta (nt ortoos hõõrub, häbeneb rulaatoriga liikuda), siis tuleb hinnata piiranguid, mida inimene kogeb tegevuse sooritamisel ilma abistaja/abivahendita.

Inimese taustainfo ja sotsiaalne võrgustik

Abivajaduse hindamise alustamisel teeb STAR2 infosüsteem automaatsed päringud erinevatesse riiklikesse andmebaasidesse ning kuvab hinnatava inimese taustainfo lehel järgnevat:

- **eestkoste (RR)** - isiku teovõime ja eestkostja andmed (kas inimese teovõime on piiratud, kes on määratud eestkostjaks ning kui pikaks perioodiks eestkostja on määratud);
- **haridus (EHIS)** - isiku hariduse andmed (kas inimene õpib ja milline on omandatud kõrgeim haridustase);
- **hüvitised (SKAIS)** - isiku hüvitiste andmed (kas ja milliseid väljamakseid (pensionid, toetused, hüvitised) inimene saab);
- **puuded (SKAIS)** - isikule määratud puude andmed (kas inimesel on tuvastatud puude raskusaste);
- **ravikindlustus (KIRST)** - isiku tervisekindlustus ja perearsti andmed (kas inimene on ravikindlustatud ning millise perearsti nimistusse ta kuulub);
- **sissetulekud (TSD)** - isiku sissetulekute andmed tööandjate ja nende poolt tehtud väljamaksete alusel (kas inimesel on maksustatav sissetulek Maksu- ja Tolliameti andmetel);
- **töötamine (TÖR)** - isiku töötamise andmed (kas inimese töötamine on Töötamise registris (TÖR) registreeritud ning tööandja nimi);
- **töötuna arveolek (Töötukassa)** - isiku töötuna arveloleku andmed koos individuaalse tööotsimiskava ja töötukassa konsultandi andmetega;
- **töövõime (TETRIS)** - isiku töövõime andmed (kas inimesel on tuvastatud puuduv, osaline või täielik töövõime).

Lisaks on vajadusel võimalik manuaalselt teha täiendavaid päringuid Liiklusregistrisse isikule kuuluvate või kasutada olevate sõidukite ja E-Kinnistusraamatusse isikule kuuluva kinnisvara kohta või alгатada uuesti automaatspäringuid andmete uuendamiseks.

Kui päring mõnda eelpool nimetatud andmebaasi ebaõnnestub, siis kuvatakse vastava taustainfo lahtris kiri „Päring ebaõnnestus“. Kui taustainfo lahtrisse on märgitud „-“, siis see tähendab, et vastavas andmebaasis andmed puuduvad.

Sotsiaalse võrgustiku alla tuleb kirja panna need inimesed **väljaspool hoolekandeesutust ja/või teenuseosutajaid**, kes on hinnatava inimesega olulises seoses ning kes mõjutavad inimese igapäevast toimetulekut. Sotsiaalse võrgustiku liikmeks võib olla näiteks abikaasa, elukaaslane, ema-isa, sõber, kolleeg, naaber jne. Iga sotsiaalse võrgustiku liikme kohta tuleb märkida ka hinnang omavahelisele suhtele. Sotsiaalse võrgustiku liikmete alla lisatakse ka eestkostja andmed. **Riiklike teenuste vajaduse hindamisel on eestkostja olemasolul vajalik ära märkida tema kontaktandmed ning „Hinnang suhtele“ all välja tuua, millistes ülesannetes eestkoste on määratud.**

Hindamisvahendi eluvaldkondadel põhinev struktuur ja põhimõtted RFK-st lähtuvalt

Inimese abi- ja toetusvajaduse hindamisel on kasutusele võetud eluvaldkondade põhine hindamismetoodika, mis tugineb Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt soovitatud elukvaliteedi³ instrumendile *WHOQOL*⁴. Täisealise abi- ja toetusvajaduse hindamise käigus hinnatakse inimese iseseisvat toimetulekut ja abivajadust **seitsmes eluvaldkonnas** (Tabel 1), mis käsitleb inimest kui tervikut, võttes arvesse nii tema tervises seisundit, organismi funktsioone, inimese tegutsemis- ja osalusvõimet kui ka teda ümbritsevat keskkonda ja personaalseid tegureid.

ELUVALDKOND	ALAMVALDKONNAD	PÕHIKÜSIMUSED
1. SUHTLEMINE	Sotsiaalsed suhted	Kas inimene suudab iseseisvalt suhelda teiste inimestega, luua uusi suhteid või säilitada olemasolevaid?
2. VAIMNE TERVIS	Kognitiivne võimekus	Kas inimene suudab iseseisvalt teha otsuseid igapäevaelu küsimustes ning orienteeruda ajas, kohas ja inimestes?
	Psüühiline seisund	Kas inimese psüühika on normipärane ja puuduvad psüühikahäirest tulenevad mõjud käitumisele ja tegevusele? Kas inimesel on haigusteadlikkus ja suudab iseseisvalt järgida raviplaani?
	Riskivaldkonnad	Kas inimese käitumine on adekvaatne ja puudub riskikäitumine, mis ohustab tema

3 Elukvaliteet on WHO määratlusel inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega.

4 WHOQOL - The World Health Organization Quality of Life Instruments (THE WHOQOL-100 and THE WHOQOL-BREF).

		enda või teiste turvalisust ja emotsioonidega toimetulekut? Kas inimese elukeskkond ja sotsiaalne võrgustik on turvalised?
3. FÜÜSILINE TERVIS	Tervise eest hoolitsemine	Kas inimene suudab iseseisvalt hoolitseda oma füüsilise tervise eest ja kasutada tervishoiuteenuseid?
	Liikumine	Kas inimene suudab iseseisvalt liikuda eluruumides? Kas inimene suudab iseseisvalt liikuda väljaspool eluruumi?
4. ELUKESKKOND	Sobiva eluaseme saamine	Kas inimene on võimeline iseseisvalt olemasolevat eluaset säilitama või sobivat eluaset otsima või taotlema?
	Eluase ja elamistingimused	Kas inimesel on olemas sobiv elamispind? Kas inimesel on olemas võimalus abi kutsumiseks?
5. HÕIVATUS	Rakenduse leidmine ja säilitamine	Kas inimene on võimeline iseseisvalt leidma või säilitama töö, õppimise vm hõivega seotud rakendust?
	Seotus hõivega	Kas inimene on töö, õppimise või muu hõivega seotud?
	Sissetuleku säilitamine	Kas inimese töötasu on püsinud muutumatu sõltumata tervislikust olukorrast?
6. VABA AEG JA HUVITEGEVUS	Vaba aeg	Kas inimene suudab iseseisvalt oma vaba aega sisustada, leida või säilitada huvitegevuse võimalusi?
7. IGAPÄEVAELU TOIMINGUD	Rahadega toimetulek	Kas inimene on iseseisev oma rahade planeerimisel?
	Toidu valmistamine	Kas inimene suudab iseseisvalt süüa valmistada ja teha sellega seotud tegevusi?
	Söömine ja joomine	Kas inimene suudab iseseisvalt süüa-juua ja teha sellega seotud tegevusi?
	Majapidamine	Kas inimene suudab iseseisvalt teha majapidamisega seotud tegevusi?
	Enda eest hoolitsemine	Kas inimene on võimeline iseseisvalt teostama enesehooldusega seotud toiminguid?

Tabel 1. Hinnatavad eluvaldkonnad.

Vastavalt abi- ja toetusvajaduse hindamisel aluseks võetud eluvaldkondade põhisele meetodikale kuulub iga eluvaldkonna alla üks või mitu alamvaldkonda ning iga alamvaldkonnaga on seotud vähemalt **üks põhiküsimus**, millele on võimalik vastata kas „JAH“ või „EI“ - kas inimene tuleb antud eluvaldkonnas iseseisvalt toime või mitte. Põhiküsimused on üldjuhul (erandina “Hõivatus”) üles ehitatud positiivses võtmes ehk „JAH“

vastus tähendab, et hinnatavas alamvaldkonnas probleeme ei esine ning kõikidele täpsustavatele küsimustele tuleb automaatselt vastuseks “0 - probleemi ei esine”. Kui vastata „EI“ - inimene ei saa antud eluvaldkonnas hakkama, siis tuleb põhiküsimuse all olevatele täpsustavatele küsimustele vastates selgitada, millistes tegevustes ja toimingutes probleem või piirang ilmneb. Probleemi ulatuse hindamisel on aluseks **RFK**⁵ määrajate skaala vahemikus 0-4, 8 ja 9 (Tabel 2), mis määratleb probleemi mõju ulatuse inimese igapäevaelule.

0	EI OLE probleemi (0–4%)	Piiranguid ei ole, inimene ütleb, et saab tegevustega hakkama
1	KERGE probleem (5–24%)	Väikesed piirangud, kuid ei takista igapäevaelu. On esinenud mõnel päeval viimase 30 päeva jooksul
2	MÕÕDUKAS probleem (25–49%)	Piirang häirib sageli igapäevaelu, esineb pooltel päevadel nädalas . Tegevus on ilmselgelt raskemini teostatav kui teistel inimestel
3	RASKE probleem (50-95%)	Piirang takistab olulisel määral igapäevaelu, esineb väga sageli või pidevalt, tegevuse sooritamine on piiratud enam kui pooltel kordadel
4	TÄIELIK probleem (96–100%)	Piirang takistab kogu aeg igapäevaelu, esineb pidevalt, tegevuse sooritamine on väga raske, peaaegu võimatu
8	Täpsustamata	Olemasolev informatsioon ei võimalda täpsemalt probleemi raskust tuvastada
9	Mittekohaldatav	Küsimus ei ole inimese puhul asjakohane ja piirangut ei ole võimalik hinnata

Tabel 2. RFK määrajate skaala probleemi ulatuse tuvastamiseks.

Kui küsimusele vastates ilmneb, et probleemi ulatus või piirang on suurem kui “0”, siis on peale määraja valikut oluline lisada kommentaari lahtrisse ka sisuline selgitus, milles probleem või piirang täpsemalt seisneb. Kommentaaris kajastuv info on oluline andmete edastamisel teistele osapooltele (sh teenuseosutajale) ja korduval hindamisel eelmiste hindamisandmete ületoomisel.

5 **RFK** kohta loe lähemalt Lisa 2 ([LISA 2. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni põhimõtted](#)).

Kui mõnes konkreetses eluvaldkonna aspektis pole võimalik inimese abivajaduse ulatust tuvastada, siis tuleb täpsustava küsimuse määrajaks valida 8 (*olemasolev info ei võimalda probleemi ulatust täpsemalt hinnata*) või 9 (*küsimus ei ole inimese puhul hetkel asjakohane*). Selline olukord võib näiteks ette tulla siis, kui inimene pole saanud selle valdkonna tegevusi senimaani ise teha ja/või selle kohta puudub informatsioon. Määrajate 8 ja 9 kohta on rohkem näited toodud Lisas 2 (LISA 2. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni põhimõtted).

Keskkonnategurite hindamine

Valdkondade „**Mitteametlik abi**“, „**Ametlik abi**“ ja „**Abivahendid ning esemeline abi**“ all on küsimused seotud inimese elukeskkonnaga, mis hõlmab nii sotsiaalseid suhteid (nt kas inimesel on olemas tugi pereliikmetelt) kui ka füüsilist keskkonda (nt kas elukeskkond, abivahendid, ravimid vms toetavad toimetulekut). Keskkonna mõju hindamisel inimese toimetulekule RFK määrajate skaala alusel on võimalik märkida, kas inimese suhted, abivahendid, ravimid, osutatavad teenused ja muu keskkond hõlbustavad või takistavad inimese toimetulekut (Tabel 3).

0	Ei hõlbusta ega takista		
+1	KERGELT hõlbustav	1	KERGELT takistav
+2	MÕÕDUKALT hõlbustav	2	MÕÕDUKALT takistav
+3	OLULISELT hõlbustav	3	OLULISELT takistav
+4	TÄIELIKULT hõlbustav	4	TÄIELIKULT takistav
8	Täpsustamata		
9	Mittekohaldatav		

Tabel 3. Keskkonnategurite määrajate skaala.

Kui sama küsimuse juures on inimese keskkonnas nii toetust kui takistusi, siis tuleb **hinnata kõigi nende tegurite koosmõju** - määraja valikul tuleb lähtuda sellest, kas need tegurid mõjutavad inimest tervikuna pigem positiivselt või negatiivselt. Spetsialistil on seejuures vajalik lisada ka täpsustav kommentaar. Näiteks kui ühe pereliikme tugi on oluliselt hõlbustav (+3) ja teise pereliikme mõju täielikult takistav (4), siis tegurite keskmine on kergelt takistav (1).

Näide: Vanaema toetab tütre tütre iseseisvat elamist, aitas teda elukoha leidmisel ja jälgib tema vaimset tervist. Ema on aga vaimselt vägivaldne ning mõjutab oma käitumisega tugevalt tütre enesehinnangut. Tegurite koosmõju on keskmiselt positiivne, sest vanaema toetuse mõju on suurem.

3. Täisealise abivajaduse hindamisküsimustiku ülesehitus

Järgnevalt antakse juhised ja soovitused iga konkreetse **elualdkonna juures olevate alamvaldkondade** (Tabel 1) kohta andmete kogumiseks. Erinevaid valdkondi ja nende alamvaldkondi puudutavad detailsemad abistavad küsimused on toodud juhendi Lisas 1. Alamvaldkondade juurde lisatud näited toetavad valdkonna eesmärgist arusaamist ning abistavad hindamisküsimustikku täites kommentaari lahtri täitmist.

1) SUHTLEMINE

- Sotsiaalsed suhted

Sotsiaalsete suhete põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt suhelda, luua suhteid ja säilitada suhteid** - eesmärgiks on saada ülevaade, kuidas inimene on suuteline iseseisvalt suhtlema. Siin on mõeldud nii enese väljendusoskust kui ka seda, kas inimese kõne on teistele arusaadav või vajab ta enda mõistetavaks tegemisel pereliiget, abistajat või abivahendeid. Lisaks on siin valdkonna all võimalik hinnata, kuidas inimene tuleb toime suhtlemisel nii lähedaste, võõraste kui ka ametiisikutega.

***Näide:** Inimese eneseväljendusoskus ja kõne mõistmine võimaldavad suhtlemist sõprade või pereliikmetega, kuid ametiasutustes asjaajamise puhul jääb keerulisemate erialaste terminite või juhiste mittemõistmise tõttu hätta.*

2) VAIMNE TERVIS

- Kognitiivne võimekus

Kognitiivse võimekuse põhiküsimuse - **inimese suutlikkus teha iseseisvalt otsuseid igapäevaelu küsimustes, orienteeruda ajas, kohas ja inimestes** - eesmärgiks ei ole hinnata kognitiivset võimekust tervikuna, vaid seda, kas inimese kognitiivne võimekus piirab tema otsustus- ja orienteerumisvõimet eelnimetatud küsimustes. Spetsialistil on vajalik otsustada kuivõrd **vajab** inimene kognitiivse võimekuse piiratus tõttu **toetust ja/või kõrvalabi**. Küsimus puudutab ka igapäevaste oluliste asjade meelespidamist, kuid ei puuduta ebaoluliste või minevikus toimunud üksikasjade mäletamist. Oluline on tähele panna, kui hästi püsib inimesel meeles teha talle või tema perele olulisi toiminguid ja täita oma kohustusi. Kui ta kasutab üldjuhul abivahendeid, mis aitavad asju meeles pidada (näiteks teeb märkmeid, kasutab elektroonilisi meeldetuletussüsteeme või sõnalisi meeldetuletusi isiklikult abistajalt), hinnake sooritust abistavaid lahendusi arvesse võttes.

***Näide 1:** Algava dementsuse tõttu on inimesel raskusi sooritamist vajavate tegevuste meelespidamisega, nt arvete maksmise, kokkulepitud kellaegadest kinnipidamise, rohtude võtmise või muu sellisega. Inimene lubab tööle või arsti juurde minna, kuid unustab selle või ajab kuupäevad sassi.*

***Näide 2:** Inimene märkab, et kraan ei tööta või aken ei sulgu korralikult, kuid ei oska kusagilt abi küsida.*

***Näide 3:** Inimene oskab ja suudab visualiseeritud päevakava abil igapäevaseid tegevusi teha.*

- Psüühiline seisund

Psüühilise seisundi alamvaldkonna all on kaks põhiküsimust. Esimese põhiküsimuse - **inimese psüühika normipärasus ja psüühikahäire mõju tema käitumisele ja tegevusele** - eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd inimese vaimse tervise probleemid ja muud vaimse tervisega seotud haigused/häired takistavad tema toimetulekut ja igapäevast elukorraldust. Hindamisel tuleb mõelda ja arvestada, kuivõrd avaldab inimese psüühiline seisund mõju tema käitumisele ja tegevustele ning kui suur on selle tõttu tema abivajadus.

***Näide 1:** Inimesel on suured nutuhood, muutub puhuti agressiivseks, ei käi ärevuse tõttu väljas.*

***Näide 2:** Suudab endale ilmastikule vastavad riideid valida ja riietuda ainult siis, kui teda juhendatakse ja aidatakse.*

***Näide 3:** Inimene suudab suhelda võõrastega ainult omale tuttava isiku juuresolekul.*

Teise põhiküsimuse eesmärgiks on hinnata **inimese haigusteadlikkust ja suutlikkust raviplaani järgida**. Oluline on välja selgitada, kuivõrd on inimesel vaja toetust seoses tema vaimse tervisega, kas inimene tunnistab oma seisundiga kaasnevat ravivajadust ning koostöö tegemist tervishoiuspetsialistidega. Siia tuleb juurde märkida, kas inimene oskab või tahab ravimite võtmisel järgida arstide poolt ette antud instruksioone ja neid iseseisvalt võtta, kas suudab raviplaani järgida, kas eirab ravimite võtmist või peidab etteantud ravimeid, ravimite võtmine vajab kontrollimist või on ravimisõltuvus. **Pane tähele!** Siin valdkonnas ei hinnata, kuidas ravimid ja tervishoiuteenused inimese iseseisvat toimetulekut mõjutavad, see info tuleb märkida "Ametliku abi" tervisevaldkonna teenuste küsimuse alla. Seega kui inimesel ei esine vaimse tervise probleeme, ta mõistab oma tervises seisundit ja järgib tervisevaldkonna spetsialistide juhiseid, siis saab valdkonna põhiküsimusele "Kas inimesel on haigusteadlikkus ja suudab iseseisvalt raviplaani järgida?" vastata "JAH" ehk probleemi ei esine.

- Riskivaldkonnad

Riskivaldkonna osa koosneb kahest põhiküsimusest. Esimese põhiküsimuse - **inimese adekvaatne käitumine ning ennast ja teisi ohustav riskikäitumine** - hindamisel tuleb olemasolevale teabele tuginedes otsustada, kas esineb riskikäitumist või nende ilminguid. Kommentaarides kirjeldada ohumärke, käitumist või tegevusi, mis võivad viia riskikäitumise vallandumisele.

Teises põhiküsimuses tuleb hinnata, kas **inimese elukeskkond on turvaline ja milline on tema sotsiaalne võrgustik**. Kui elukeskkond ja sotsiaalne võrgustik ei ole turvalised, siis täpsustavate küsimuste juures ei ole vaja määrata raskusastet, vaid linnukesega märkida, kas inimene tunneb **hirmu, tema suhtes kasutatakse erinevaid vägivaldavorme, teda koheldakse alavääristavalt või piiratakse tema vaba liikumist**. Võimalik on lisada ka „Muu“ variant ning seda kommentaariga täpsustada.

***Näide:** Ratastoolis inimest ei viida või ei lubata õue, tema suhtlemist teiste inimestega piiratakse või võetakse ära tema pangakaart.*

3) FÜÜSILINE TERVIS

- Tervise eest hoolitsemine

Tervise eest hoolitsemise põhiküsimuse - **inimese suutlikkus oma füüsilise tervise eest hoolitseda ja tervishoiuteenuste kasutamine** - eesmärgiks on teada saada, kuivõrd on inimesel abi vaja somaatilistest haigustest ja üldisest füüsilisest tervisest tulenevalt. Oluline on ära märkida, kas inimesel on somaatilisi haigusi, mis vajavad regulaarselt jälgimist. Kaebuste või valude esinemisel hinnata, kas inimene suudab endale nii pere- kui eriarsti juurde visiidiaega broneerida, iseseisvalt või koos abistajaga arsti vastuvõtule minna või analüüse anda.

- Liikumine

Liikumise alamvaldkond koosneb kahest põhiküsimusest. Esimese põhiküsimuse - **inimese suutlikkus liikuda oma eluruumides** - eesmärgiks on teada saada, kas inimene vajab toetust ja abi seoses liikumisega igapäevastes eluruumides.

***Näide:** Tulenevalt parema jala lihasnõrkusest ei suuda liikuda ilma abistajata teisel korrusel asuvasse magamistuppa.*

Teise põhiküsimuse - **inimese suutlikkus liikuda väljaspool eluruume** - eesmärgiks on tuvastada, kas ja millist abi vajab inimene füüsilisel liikumisel väljaspool eluruume, transpordi planeerimisel ja kasutamisel või hõlbustavate abivahendite kasutamisel. Küsimus puudutab nii kodust väljamine misega seotud füüsilisest keskkonnast tulenevaid tegureid (trepid, astmed, kohanduste puudumine jm) kui ka kodust väljamine misega seotud emotsionaalseid või vaimseid tegureid (depressioon, ärevus, paanikahäire jne).

***Näide:** Inimene oskab liikuda oma eluruumides, kuid väljaspool kodu mitte, sest on oht ära eksida või ei suuda lii kluses ohutult hakkama saada.*

Füüsilise tervise eluvaldkonna all inimese käte funktsioonide (nt esemete haaramise või kandmise) kohta eraldi küsimusi ei ole. Käte/käte funktsioone on võimalik täpsustada igapäevaelu toimingute valdkonna all. Füüsilise tervise valdkonnas saab käe/käte funktsioone kirjeldada kommentaarina, millised tegevused ja millisel määral on raskendatud.

***Näide:** Inimesel esinevad tasakaaluhäired ja käte lihasnõrkus, mistõttu on tal raskusi trepi käsipuust kinnihoidmisel ja treppidest liikumisel.*

4) ELUKESKKOND

- Sobiva eluaseme saamine/säilitamine

See alamvaldkond koosneb ühest põhiküsimusest – **inimese võimekus olemasolevat eluaset säilitada või uut ja sobivat eluaset otsida** - eesmärgiga tuvastada, kas inimene vajab abi, et tema olemasolev eluase säiliks või vajab ta abi uue eluaseme otsimisel. Näiteks, kui inimene elab isiklikus korteris, majas, sotsiaalkorteris või ka teenuseosutaja poolt tagatud pinnal, siis kas ta tuleb iseseisvalt toime maksete tasumisega ja suhtlusega asjaajamisel kommunaal- või haldusküsimustes. Kui inimene vajab uut eluaset, siis kas ta on võimeline otsima eluaset

üüriturult või taotlema sotsiaaleluruumi. Samuti hinnata, kuidas inimene saab hakkama oma vara hooldamise ning koduloomade eest hoolitsemisega.

- Eluase ja elamistingimused

Eluase ja elamistingimused alamvaldkond koosneb kahest põhiküsimusest. Esimese põhiküsimuse - **elamispinna olemasolu** - eesmärgiks on teada saada, kas inimese praegune eluase vastab tema vajadustele ja on turvaline või vajab see kohandamist või tuleb hoopis kolida. Küsimuse juures on „Lisainfo“ lahter, kuhu on võimalik „EI“ vastuse korral täiendavalt kirjeldada, millised on inimese täpsemad vajadused elamispinna osas.

Näide 1: *Inimene elab koos oma vanematega, kuid suhted on konfliktised ning halvendavad oluliselt tema vaimset tervist, mille tõttu on vajalik asuda vanematest eraldi elama.*

Näide 2: *Inimene elab ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel, kuid tegelikult on tema võimed ja suutlikkus iseseisvalt toime tulla paremad. Ta võiks elada oma kodus iseisevalt või toetatud abiga (nt tugisikuteenus, igapäevaelu toetatud teenus).*

Teise põhiküsimuse - **inimese võimalus abi kutsuda** - eesmärgiks on hinnata, kuidas inimene saab hakkama abi kutsumisega näiteks kasutades telefoni või häirenuppu ning teab, kelle poole abi saamiseks pöörduda (sh Häirekeskusesse).

5) HÕIVATUS

- Rakenduse leidmine ja säilitamine

Rakenduse leidmise ja säilitamise põhiküsimuse - **inimese võimekus iseseisvalt leida või säilitada töö, õppimisega või muu hõivega seotud rakendus** (sinna hulka kuulub ka vabatahtlik töö ja rakendus kogukonnas) - eesmärgiks on tuvastada, kas inimene vajab toetust, et leida võimalusi õppimiseks, töötamiseks, töökoha säilitamiseks või töösarnase tegevuse leidmiseks oma kogukonnas. Seejuures tuleb hinnata, kas inimene on võimeline õigel ajal tööle jõudma, tööülesandeid täitma, tegevusi kavandama ja ellu viima. Siinkohal ei märgita aga seda, kas inimene on töö või õppimisega hõivatud, see on oluline järgmise üldküsimuse juures.

- Seotus hõivega

Seotus hõivega põhiküsimuse - **inimese seotus töö, õppimisega või muu hõivega** - eesmärgiks on tuvastada, kas inimene on hetkel hõivega seotud ja kas see vastab tema võimekusele ja vajadustele. Alamküsimuste juures on võimalik täpsustada, millega inimene täpsemalt tegeleb - täistööajaga või osalisel tööajaga töötamisega, eraettevõtlusega, koolihariduse, kutsehariduse või kõrghariduse omandamisega või täiendõppes/tööpraktikal osalemisega. Juurde saab lisada, millised piirangud esinevad hõives osalemisel.

Näide: *Inimene töötab osalise tööajaga, aga ta ei ole rahul sissetuleku suurusega, sest see ei ole eluasemekulude tasumiseks piisav.*

Pane tähele! Hõivatuse valdkonna põhiküsimuse vastuse ja täpsustavate küsimuste seos on ülejäänud küsimustiku hindamisloogikaga võrreldes vastupidine! Kui üldküsimusele

vastata “EI”, mis tähendab, et inimene EI OLE hõivega seotud, siis täpsustavatele küsimustele probleemi ulatuse määrajat ja kommentaare lisada ei saa (v.a. valdkonna üldkommentaar, mida saab alati lisada).

Kui põhiküsimusele vastata “JAH”, mis tähendab, et inimene ON hõivega seotud, siis saab täpsustavatele küsimustele vastates hinnata, kas hõives osalemisega seonduvalt esineb ka abivajadus ja millises ulatuses probleem esineb.

Hõive valdkonna alamküsimuses “Seotus hõivega” tuleb hinnata hetkeolukorda. Varasemalt omandatud haridus, läbitud koolitused või omatud töökohad ei kuulu selle punkti all hindamisele, need andmed kajastuvad inimese taustainfo lehel. Küll aga on võimalik neid vajadusel täpsustada kommentaaride lahtris.

- Sissetuleku säilimine

Sissetuleku säilitamise põhiküsimuse - **inimese töötasu või muu sissetulek (nt töövõimetoetus või puudega inimese sotsiaaltoetus) on püsinud muutumatu sõltumata tema tervislikust olukorrast** - eesmärgiks on tuvastada, kas inimene on pidanud tervise halvenemise tõttu tööst loobuma ja tema sissetulek on seetõttu vähenenud. See võib omakorda mõjutada inimese majanduslikku turvalisust.

6) VABA AEG JA HUVITEGEVUS

- Vaba aeg

Vaba aja põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt oma vaba aega sisustada, leida või säilitada huvitegevuse võimalusi** - eesmärgiks on tuvastada, kas inimene vajab abi, et leida tegevusi, mis jäävad väljaspoole igapäevaelu kohustuslikke toiminguid ja töiseid tegevusi. Samuti, kas inimene suudab töö ja puhkuse vahel tasakaalu hoida, huvitub ning käib erinevatel kultuuriüritustel ja kas inimesel on võimalus ennast teostada läbi mõne huvitegevuse või kogukondliku tegevuse (näiteks päevakeskuse huviringides).

Pane tähele! Juhul kui vaba aja ja huvitegevuste alamvaldkonnas esinevad olulised piirangud, kuid tulenevalt inimese üldseisundist ei ole otstarbekas määrata sekkumist, siis tuleb ära märkida vastava piirangu ulatusega määraja ning lisada selgitav kommentaar, mitte aga valida määrajaks “9”.

7) IGAPÄEVAELU TOIMINGUD

- Rahadega toimetulek

Rahadega toimetuleku põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt oma raha planeerida ning asjaajamisega toime tulla** - eesmärgiks on tuvastada, kas inimesel on võimekus planeerida oma eelarvet, rahaliste vahenditega kuu lõpuni toime tulla, oskused pangateenuseid kasutada ja näiteks internetipangas arveid tasuda või püsimaksekorraldust sõlmida. Eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd vajab inimene abi oma rahaasjade korraldamisel või on tal

võlgnevusi, millega ta ei tule ise toime. Oluline on ära märkida ka see, kas inimene suudab planeerida igapäevaeluks vajalike ostude tegemist ja selleks kuluvaid vahendeid (nt ostab kokku liiga palju toiduaineid, mida ta ära tarbida ei jõua või riideesemeid, mida ta otseselt ei vaja).

Näide 1: *Inimene kulutab kogu oma laekunud sissetuleku (palk, toetused) nädalaga ära, mis tähendab, et tal on tõenäoliselt vaja abi ja juhendamist oma igakuiste kulutuste planeerimisel ja ostude tegemisel.*

Näide 2: *Inimene kardab sisestada PIN-koodi, vajab abi ja julgustamist PIN-koodi sisestamisel.*

Näide 3: *Inimene soovib kasutada internetipanka, kuid tal puuduvad digioskused ja ta vajab selles juhendamist.*

- Toidu valmistamine

Toidu valmistamise põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt süüa valmistada ja teha sellega seotud tegevusi** - eesmärgiks on tuvastada, kas inimene vajab abi tegevustes, mis on seotud toidukaupade ostmise ja koju toomisega, nii külma kui kuuma toidu valmistamise ja soojendamisega. Lisaks, kuidas saab inimene hakkama toidu lauale viimise ning pärast söömist laua koristamisega.

- Söömine ja joomine

Põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt süüa-juua ja teha sellega seotud tegevusi** - eesmärgiks on tuvastada, millisel määral vajab inimene abi kõikides söömise ja joomisega seotud tegevustes. Näiteks, kuidas ta saab hakkama söögiriistade kasutamisega, toidu tükkideks lõikamisega, joogi klaasi valamise või toidu taldrikule tõstmisega, toidu või joogi allaneelamisega. Kui on probleeme käelise tegevusega, siis siin on asjakohane hinnata käte funktsionaalsust, koordineerimist, jõudlust (sh lihasnõrkust ja -värinat). Samuti on oluline välja tuua toitumisega seotud eripärad - näiteks keeldub söömast teatud toite, sööb liiga kiiresti, neelab alla suuri toidutükke vms.

- Majapidamine

Majapidamise põhiküsimuse - **inimese suutlikkus iseseisvalt teha majapidamisega seotud tegevusi** - eesmärgiks on tuvastada, millisel määral vajab inimene abi majapidamisega seotud tegevustes, et tema eluruumid ja riided oleksid puhtad ja ümbritsev keskkond oleks elamisväärne ning korras. Majapidamistoimingute all on silmas peetud nt nii tolmu võtmist, põrandate puhastamist, akende pesemist kui ka vannitoa puhastamist jne. Samuti, kas inimene saab hakkama kodumasinate käsitsemisega või vajab seejuures kõrvalist abi. Siinkohal on oluline ära märkida, kui inimene suudab küll füüsiliselt tegevusi teha, aga vajab selleks meeldetuletamist, suunamist või juhendamist.

- Enese eest hoolitsemine

Enese eest hoolitsemise põhiküsimuse - **inimese võimekus iseseisvalt teostada enesehooldusega seotud toiminguid** - eesmärgiks on tuvastada, millisel määral vajab inimene

abi enda eest hoolitsemisel. Siinkohal tuleb arvesse võtta ka käte ja sõrmede liikuvust, mis on vajalik riiete kättesaamiseks, selga panemiseks. Oluline on ära märkida, kas esineb probleeme riietusesemetel või jalanõudel olevate erinevate kinnistega (lukud, nööbid, haagid, paelad) või on inimene kohanenud ja kannab ainult neid riideid, millel keerulisemaid kinniseid ei ole. Hinnata, kas inimene oskab valida ilmastikule vastavaid riided, märkab märdunud riideid vahetada ja on suuteline regulaarselt, ilma juhendamise või meeldetuletamiseta, hügieenitoimingutega hakkama saama. Kui inimene kasutab üle kogu keha pesemiseks abivahendeid (nt pikendatavat pesemisharja ja duššitooli), need on tavapärases, koduses keskkonnas alati kättesaadavad ja inimene saab pesemistoimingutega iseseisvalt hakkama, siis tuleb pesemistoimingutega seotud raskuseid hinnata arvestades abivahendite kasutamist. Kommentaarina tuleb lisada see, kui inimene vajab pesemisel teise inimese abi või kas ta lubab teistel end aidata. Kui abivahenditega on tervises seisundist tingitud raskused kompenseeritud, siis valige määrajaks “0”.

4. Kõrvaline abi, abivahendid ja eluruumi kohandamine

See hindamisvahendi osa käsitleb **keskkonnategureid** (vt Tabel 3) ehk milliste abimeetmetega ja kelle poolt on täna inimesele abi korraldatud. Abi korraldust on võimalik hinnata kolmes osas: 1) mitteametlik abi 2) ametlik abi, toetused-teenused ja 3) abivahendid ja esemeline abi.

“**Mitteametlik abi**” võib olla korraldatud inimese pere või lähivõrgustiku poolt (lähisugulased, tuttavad, naabrid) ja “**Ametlik abi**” tagatud mõne hoolekande-, tervishoiu- või töövaldkonna teenusega, kuid inimese jaoks võivad olla vajalikud ka muud teenused, mida talle täna ei pakuta. Sellisel juhul tuleb tagada lisaks sobiv teenus ja/või toetus, et inimene ei jääks abitusse olukorda.

“**Abivahendid ja esemeline abi**” all tuleb ära märkida, kas inimene kasutab oma toimetulekuks abivahendeid. Kui jah, siis nimetada abivahend(id), mida inimene kasutab, kas need on töökorras ja igapäevaselt kasutusel ning toetavad iseseisvat hakkamasaamist. Samuti saab täpsustada, kas abivahendit kasutatakse kodus või väljaspool kodu.

Esemelise abi alla kuulub ka eluruumi kohandamise vajaduse hindamine ehk kas inimese eluruum on kohandatud tema abivajadust silmas pidades, näiteks ligipääsuks eluruumidesse või kohandused siseruumis (köögis, vannitoas, magamistoas vm).

Lisaks on esemelise abi all välja toodud rahalised vahendid ning muu inimese omandis olev vara, mis saab toetada või takistada inimese majanduslikku toimetulekut.

Juhul kui kõikide või enamuse eluvaldkondade osas selgub, et inimese abistamine ja toetus on tagatud pereliikme(te) poolt, siis see tähendab, et tegemist on suure hoolduskoormusega pereliikme(te)ga, kes vajavad tõenäoliselt ise toetust. **Sellisel juhul tuleb kindlasti tegeleda pereliikme(te) nõustamisega ja pakkuda võimalusi nende hoolduskoormuse vähendamiseks.**

5. Inimese olulisemad vajadused

Kui inimese abivajadus kõikides eluvaldkondades on välja selgitatud, tuleb ära kirjeldada need tegevused, mis on edasise abi korraldamisel kõige olulisemad või millised toimetuleku probleemid vajavad **esmajärjekorras** sekkumist. Kuna inimese enda arusaam oma abivajadusest võib oluliselt erineda spetsialisti hinnangust, siis tuleb eraldi välja tuua nii inimese enda kui ka spetsialisti poolt nimetatud vajadused.

- Olulisemad vajadused spetsialisti ja/või lähedase hinnangul

Vajaduste kirjeldamisel tuleb ära nimetada need tegevused, mida sotsiaaltöötaja või teised spetsialistidest võrgustikuliikmed (nt raviarst, teenuseosutaja, tugiisik, tegevusjuhendaja vms), eestkostja või lähedane peavad toetuse pakkumisel kõige olulisemaks. See tähendab, mida kindlasti tuleks abi korraldamisel silmas pidada või milliste piirangute juures on vajalik kohene sekkumine. Teenuseosutaja jaoks on vajalik välja tuua teave, mis on oluline vajaduspõhiseks teenuse osutamiseks.

Pane tähele! Oluline on lähtuda põhimõttest, millised tegevused on inimese jaoks vajalikud, mitte anda hinnangut selle kohta, millega inimene toime ei tule või millist teenust peaks talle määrama.

Näide 1: *Inimene vajab juhendamist igapäevaelu toimingute sooritamisel (kodumasinade kasutamine, sooja toidu valmistamine).*

Näide 2: *Inimene vajab arsti juures käimisel kõrvalabi nii liikumisel väljaspool eluruume kui ka arsti poolt antud juhiste või selgituste mõistmisel.*

Näide 3: *Inimene vajab abi, suunamist motiveerimist ja juhendamist olemasolevate võimete säilitamiseks.*

Näide 4: *Inimene vajab abi tööl püsimiseks ning ajab abi turvalise elamispinna leidmisel ja lähisuhete hoidmisel.*

- Inimese enda nimetatud vajadused

Inimese enda poolt nimetatud vajadused, soovid ja eesmärgid tuleb eraldi välja tuua. Lähtuda tuleb, mida inimene ise soovib, kuhu tahab jõuda, mis on puudu, milles on takistus, mida ta ise peab oma toimetuleku seisukohast kõige vajalikumaks. Kui inimese enda nimetatud vajadus tundub ebarealistlik, siis mõelda laiemalt - millest peaks alustama, et soovitud suunas liikuma hakata. Kui inimene ei oska hindamise ajal nimetada vajadusi oma toimetuleku parandamiseks, siis tulebki hindamisel märkida: "*Ei oska nimetada*". Kui inimesel enda arvates pole üheski valdkonnas vajadusi, siis saab märkida: "*Pole vajadusi*".

Näide 1: *Peeter tunneb, et vajab ühte kindlat usaldusisikut, kelle poole igal hetkel pöörduda ja kes teda kõige paremini mõistab.*

Näide 2: *Mari soovib rohkem värskes õhus viibida kuna liikumispiirangu tõttu ei saa ta isesesivalt õue.*

Näide 3: Pille ei saa hakkama digiteenuste kasutamisega ning vajab ametiasutustega asjaajamisel juhendamist.

Näide 4: Paul soovib endale palju sõpru, kuid on suhtlemisel pealetükkiv ning püsivaid sõpru tal ei ole. Vajab abi suhete loomisel ja säilitamisel.

6. Otsustustugi abimeetme valikul

Hindamistulemuste põhjal tekib “Vajadused” all loetelu eluvaldkondadest, milles inimesel esineb abivajadus ehk välja on toodud need valdkonnad, kus probleemi ulatuse määraja on suurem kui “0”. Selle alusel on võimalik otsustada, kas inimene vajab toimetulekuks ja ühiskonnaelus osalemiseks kõrvalabi ning millistes eluvaldkondades see täpsemalt vajalik on.

STAR2-s olevas küsimustikus on sobivate abimeetmete valikuks olemas **otsustustugi**. Tegu ei ole automaatselt abimeetmeid pakkuva seadistusega, vaid toimetulekut toetavate eesmärkide, tegevuste, tegevusi teostavate spetsialistide ja hoolekandeteenuste loeteluga, mis suunab hindajat läbi mõtlema, millisest sekkumisest võiks inimesel kõige enam kasu olla. Inimese jaoks kõige sobivamad abimeetmed märgib spetsialist linnukesega, kuid see ei tähenda, et inimene on kõiki neid abimeetmeid kohustatud saama. **Kui hindamist viib läbi Sotsiaalkindlustusameti spetsialist, on riiklikult korraldatavate teenuste määramisel kohustus märkida ära kõik need teenused, mille teenuse vajadus on tuvastatud.**

Pärast abimeetmete valikut sõnastab spetsialist **ettepaneku abimeetme rakendamiseks, seatud eesmärgi** ning millis(t)e olemasoleva(te) sotsiaalhoolekande või muu sidusvaldkonna abimeetme(te)ga on võimalik inimese toimetulekut toetada.

Kui inimese abivajaduse ulatus ei ole üheski valdkonnas suurem kui mõõdukas ehk raskuste on vahemikus 0-2, tuleb kaaluda abimeetmetena toetavaid tegevusi, mis ei ole ööpäevaringsed ja mida reeglina osutatakse inimese kodus. Kui inimese abivajaduse raskusaste on enamikes valdkondades vahemikus 3-4 ja puudub toetav võrgustik, on üsna tõenäoline, et inimene vajab toimetulekuks ööpäevaringseid abimeetmeid. Samas võib inimesel olla sotsiaalsete suhete valdkonnas äärmuslik toetusvajadus ehk raskusaste 4 kuna ta on kõnetu, kuid see ei tähenda, et ta vajaks ööpäevaringset teenust - ta võib vajada suhtlemiseks hoopis abivahendit, mida vajadusel kasutada saab.

Kui inimesel on olemas tugivõrgustik, kes on valmis panustama ööpäevaringse abi tagamisel, tuleb kaaluda, kuidas ja milliste abimeetmetega on võimalik tagada inimesele ja tema perele vajalikud lahendused, mis toetavad hooldusvajadusega inimeste toimetulekut nende endi kodus nii kaua kui võimalik ning aitavad vähendada lähedaste hoolduskoormust.

LISA 1. Abistavad küsimused

Eluvaldkondade alamküsimustele probleemi ulatuse määrajat valides saab tugineda alltoodud abistavatele küsimustele. Vastavalt hinnatava inimese erivajadusele saab ilmnunud asjaolusid kirjeldada ka alamküsimusele kommentaari lisades (kui kommentaar puudutab konkreetselt käsitletavat alamküsimust) või vastava eluvaldkonna üldise kommentaari lahtrisse (kui kommentaar on üldisemat laadi ja seda ei ole võimalik siduda ühegi konkreetse alamküsimusega).

Valdkond 1: SUHTLEMINE

Sotsiaalsed suhted

1.Kas inimene suudab iseseisvalt suhelda teiste inimestega, luua uusi suhteid või säilitada olemasolevaid?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem kõnest arusaamisel ja suuliste sõnumite otsese või ülekantud tähenduse mõistmisel?	Kas inimene saab aru lihtsast igapäevasest jutust? Kas inimene saab aru keerulisemast ja võõrsõnu sisaldavast jutust või kirjutatust (nt ajaleheartiklitest)? Kas inimene saab aru ka öeldu/kirjutatu kaudsest tähendusest? Kas teiste jutust arusaamine võimaldab vaba suhtlemist pere, sõprade ja tuttavatega? Kas teiste jutust arusaamine võimaldab ajada asju ametiasutustega (nii otse kui ka kirja teel)? Kas kasutab sõnumite vastuvõtmiseks alternatiivkommunikatsiooni vahendeid (PCS-pilte, piktogramme, enda loodud vm märke)?	d310	Suuliste sõnumite vastuvõtmine suhtlemisel
2.	Mil määral esineb probleem verbaalse kõnega e rääkimisega (sõnade ja fraaside kasutamine, loo jutustamine,	Kas on olemas verbaalne kõne? Kas räägib üksikuid sõnu või täislausetega? Kas esineb kajakõne (kordab teise sõnu või lauseid)? Kuidas end kõnes väljendab (miimika, žestid, liigutused, häälitsemine, naer, nutt, hääletoonid, kõne rõhuasetused, intonatsioon ja pausid)? Kas suudab sõnadega väljendada oma soove/valu/vajadusi?	d330	Rääkimine

	selgituste andmine, juhiste küsimine)?	Kas kasutab enese väljendamiseks alternatiivkommunikatsiooni vahendeid (PCS-pilte, piktogramme, enda loodud vm märke)?		
3.	Mil määral esineb probleem vestluse alustamisel, ülevõetamisel ja lõpetamisel?	Kas suudab osaleda dialoogis? Kas inimene räägib ja küsib ise küsimusi? Kas oskab arutleda ja diskuteerida? Kas oskab vestluse sotsiaalselt sobival viisil lõpetada? Kas oskab vestlemisel kuulata ka teist inimest või räägib vahele?	d350	Vestlemine
4.	Mil määral esineb probleem teiste inimestega suhtlemisel, suhtluse hoidmisel ja säilitamisel vastavalt sotsiaalsetele normidele?	Milline on inimese läbisaamine teiste inimestega (pere, teised olulised inimesed)? Kas inimesele meeldib teistega suhelda? Kas on vestluses sõnaahter ja võtab pigem kuulaja rolli? Kas teised tahavad inimesega suhelda, milline on teiste suhtumine? Kas on suhtlemisel pigem pealetükkiv või passiivne ja tagasihoidlik? Kas loob kontakte teistega arvestavalt või enesekeskselt? Kellega eelistab suhelda ja kellega tekib hea kontakt?	d720	Keeruline inimestevaheline lävimine
5.	Mil määral esineb probleem võõraste inimestega kontakti loomisel, nt teejuhiseid küsides või sisseoste tehes?	Kas julgeb vajadusel kontakteeruda võõra inimesega (ka abi palumiseks)? Kas on võõrastega suhtlemisel enesekindel ja tunneb ennast mugavalt või pigem on kartlik? Kas oskab/julgeb väljendada oma arvamust?	d730	Võõrastega kontakteerumine
6.	Mil määral esineb probleem ametlikes tingimustes suhtlemisel, nt õpetajatega, tööandjatega,	Milline on inimese läbisaamine teiste inimestega (töökaaslastega, ülemustega, ametnikega vms) ametlikus kontekstis või töökeskkonnas? Kas oskab/julgeb väljendada oma arvamust? Kas oskab ametlikus suhtluses olla reserveeritud ning mitte pealetükkivalt sõbralik?	d740	Ametlikud suhted

	ametiisikutega või teenusepakkujatega?			
7.	Mil määral esineb probleem mitteametlike sotsiaalsete suhete loomisel, nt sõprade, naabrite, kolleegide, eakaaslaste, tuttavatega?	Kas oskab hoida suhteid sõprade või tuttavatega? Kas vajab suhtlemisel abi? Kas oskab/julgeb väljendada oma arvamust? Kas on domineeriv/hooliv/pealetükkiv/passiivne? Kas saab aru, kui temaga suhtlemine ei ole soovitud? Kas peab kinni kokkulepetest ja mõistab kokkulepete tähtsust suhete hoidmisel?	d750	Mitteametlikud sotsiaalsed suhted
8.	Mil määral esineb probleem perekondlike suhete loomisel ja säilitamisel, nt vanemate, laste, õdede-vendade või laiendatud perekonnaga?	Kas oskab hoida suhteid pereliikmetega ja sugulastega? Kas oskab kuulata ja mõista suhtlemisel teist inimest? Kas oskab/julgeb/tahab väljendada oma arvamust pereringis? Kas oskab arvestada partneri arvamuse/tunnetega?	d760	Perekondlikud suhted

Valdkond 2: VAIMNE TERVIS

Kognitiivne võimekus

1.Kas inimene suudab iseseisvalt teha otsuseid igapäevaelu küsimustes ning orienteeruda ajas, kohas ja inimestes?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
----	---------	---------------------	------	---------

1.	Mil määral esineb probleem orienteerumisel ajas – kas on teadlik kellaajast, nädalapäevast, kuupäevast, kuust ja aastast?	Kas on olemas teadlikkus nädalapäevast, kuupäevast, kuust ja aastast, kellaajast? Kas suudab eristada, mis ajahetkel mingi sündmus/tegevus aset leidis? Kas suudab eristada olevikku minevikust?	b1140	Orienteerumine ajas
2.	Mil määral esineb probleem orienteerumisel kohas – kas on teadlik oma asukohast, lähiümbrusest, linnast, riigist?	Kas on olemas teadlikkus oma asukohast ja lähiümbrusest, oma linnast või riigist? Kas suudab seostada sündmusi kohtadega, kus need aset leidsid? Kas ta teab, kus ta elab? Kas teab mõnda linna, mis kodu lähedal on? Kas on kunagi ära eksinud?	b1141	Orienteerumine kohas
3.	Mil määral esineb probleem orienteerumisel inimestes – kas on teadlik enda identiteedist ja enda ümber olevatest inimestest?	Kas on teadlik endast ja enda ümber olevatest isikutest? Kas tunneb ära ja oskab panna konteksti erinevaid inimesi (sõpru, pereliikmeid, teenuseosutajaid, avaliku elu tegelasi jt)? Kas on ajanud inimesi omavahel sassi?	b1142	Orienteerumine inimestes
4.	Mil määral esineb probleem orienteerumisel ruumis – kas on teadlik oma keha asukohast vahetus füüsilises ruumis,	Kas oskab ruumis liikuda soovitud suunas? Kas oskab minna kodus nt kööki, tualettruumi või on tubade vahel ära eksinud? Kas on oma toa asemel kogemata mõne teise inimese tuppa läinud? Kas tajub oma asukohta ruumis (nt kaugust aknast või toolist)?	b1144	Orienteerumine ruumis

	oskab leida ruumis tee kohast A kohta B?			
5.	Mil määral esineb probleem igapäevaste oluliste asjade meelespidamisel?	Kas suudab meeles pidada oma kohustusi ja enda poolt antud lubadusi? Kas suudab meeles pidada igapäevaseid rutiinseid tegevusi (nt enesehooldus, ravimite võtmine)? Kas suudab meeles pidada koduste esemete asukohta ning leiab need vaevata?	b144	Mälufunktsioonid
6.	Mil määral esineb probleem igapäevaelus ettetulevate probleemide lahendamisel?	Kas lepib ebameeldivusega ega püüagi probleemi lahendada? Kas püüab probleemide lahendamist edasi lükata? Kas püüab probleemi lahendamise suunata enda pealt kellelegi teisele? Kas oskab/julgeb/suudab abi küsida?	d175	Probleemi lahendamine
7.	Mil määral esineb probleem erinevate valikuvariantide vahel otsustamisel või tegemist vajavate ülesannete seast olulisema valimisel ning selle elluviimisel?	Kas suudab erinevaid valikuvariante kaaluda ja selle põhjal mõistlikke otsuseid langetada? Kas suudab tegevusi olulisuse või kriitilisuse järgi tähtsuse järjekorda seada? Kas on otsuste langetamisel iseseisev või toetub teistele ja laseb pigem kellelgi teisel enda eest otsustada?	d177	Otsustamine

Psüühiline seisund

1.Kas inimese psüühika on normipärane ja puuduvad psüühikahäirest tulenevad mõjud käitumisele ja tegevusele?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
.				

1.	Mil määral esineb probleem kergesti ärrituvuse, ülemäärase muresemise, tujukuse või ettearvamatu käitumisega? Kas inimene on psüühiliselt stabiilne?	Millal algasid probleemid vaimse tervisega? Kas ja millal on viibinud haiglas või hooldekodus? Kas on vaimse tervise tõttu viibinud tahte vastaselt haiglas? Kas ärritub väga kergesti ja näiliselt tühiste asjade peale? Kas käitub sageli ettearvamatult? Kas tujud, emotsioonid muutuvad kiiresti? Kas mureseb ülemääraselt ka tühiste asjade pärast?	b1263	Psüühiline stabiilsus
2.	Mil määral esineb probleem enda käitumise kontrollimisel, nt spontaansuse, ülemäärase aktiivsuse või rahutusega toimetulekul?	Kas esineb probleeme oma käitumise või emotsioonide kontrollimisega? Millistes olukordades? Kas on tuim, osavõtmatu? Kas väljendab vastavale olukorrale sobimatuid emotsioone (emotsioon ei vasta sotsiaalsele normile või olukorra kontekstile)?	b152	Emotsioonide funktsioonid
3.	Mil määral esineb probleem tegevuste sooritamisel stressirohketes ja vastutusrikkates olukordades?	Kas suudab stressirohkes olukorras säilitada otsustus- ja tegutsemisvõime? Kas väldib stressolukordi ka juhul, kui see tooks kaasa elukvaliteedi paranemise (nt väldib töökoha vahetust, ehkki teadmised ja oskused võimaldaksid töötada kõrgemini tasustatud aga vastutusrikkamal töökohal)? Kas suurema vaimse koormuse korral pigem loobub ettevõtmisest?	d240	Stressi ja muu vaimse koormusega toimetulek

2.Kas inimesel on haigusteadlikkus ja ta suudab iseseisvalt järgida raviplaani?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem oma käitumise teadvustamisel ja mõistmisel?	Kas suudab mõista ja analüüsida oma käitumise sobilikkust olukorrale? Kas enesetaju on adekvaatne (nt oma välimuse, võimete, oskuste vms osas)? Kas tunneb end võimetu, saamatuna (et temast ei sõltu mitte midagi)?	b1644	Enesetunnetus

2.	Mil määral esineb probleem koostöö tegemisel arstide või teiste spetsialistidega?	Kas aktsepteerib spetsialistide arvamust? Kas on motiveeritud ning järgib arstide ja teiste spetsialistide soovitusi või juhiseid nii ravimite võtmisel kui tervisekäitumisel?	b1261	Koostöövõimelisus
----	---	---	-------	-------------------

Riskivaldkonnad

1.Kas inimese käitumine on adekvaatne ja puudub riskikäitumine, mis ohustab tema enda või teiste turvalisust ja emotsioonidega toimetulekut?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleeme enese hoolitusse jätmisega?	Kas ei joo või ei söö korralikult (nii koguse kui toidu tervislikkuse seisukohast)? Kas hoolitseb oma füüsilise tervise eest (nt liigub piisavalt, viibib värskes õhus jms)? Kas ei taha või ei saa üldse voodist tõusta ega õue minna? Kas inimene hoolitseb oma hügieeni eest (peseb ennast jms)? Kui mitte, siis milles probleem esineb? Kas riietub ilmastikule sobivalt? Kas omab arusaamist oma elulistest ja tervislikest vajadustest?	d570	Oma tervise eest hoolitsemine
2.	Mil määral esineb probleeme ennast kahjustava käitumisega, mis kätkeb ohtu vaimsele või füüsilisele tervisele või elule?	Kas suudab vastu panna äkilisele tungivale soovile midagi endale või teistele teha (sh endale viga teha)?	b1304	Impulsside kontrollimine
3.	Mil määral esineb probleeme agressiivsuse, vägivaldsuse või vaenulikkusega?	Kas esineb vihamärke (sh kellele suunab oma viha) või vihakõnet? Mis on agressiivset käitumist või vihakõnet vallandavateks teguriteks (ohumärgid)?	d7202	Suhtlemisel käitumise kohandamine

		Kas ärritub ja võib muutuda vägivaldseks, kui temaga suhtlemine lõpetatakse (nt seetõttu, et ta on liiga pealetükkiv vm põhjusel)? Kas on esinenud vägivaldset või ohtlikuna tajutavat käitumist? Kui jah, siis kas enda, teiste inimeste või asjade vastu? Kas on ennast vigastanud?		
4.	Mil määral esineb probleeme seoses riskiga lastele või teistele, kes on inimesest sõltuvad?	Kas suudab täita vanema kohuseid ja tagada lapsele/lastele turvalist ja toetavat keskkonda? Kas on jätnud endast sõltuvaid inimesi või koduloomi hooletusse või abitusse olukorda?	d660	Teiste abistamine
5.	Mil määral esineb probleeme sõltuvusega alkoholist, uimastitest, ravimitest või muudest ainetest?	Kas esineb sõltuvust ravimitest? Kas esineb sõltuvust alkoholist? Kas esineb sõltuvust uimastitest? Kas suitsetab? Kas esineb sõltuvusainete kuritarvitamisest tulenevat käitumise muutumist ja sellega seotud ohte? Mis võib olla sõltuvusainete tarvitamise põhjus, eesmärk? Kas esineb sündsusetut seksuaalkäitumist? Kui jah, siis milles väljendub? <i>– ei pruugi sugugi olla seoses sõltuvusega, vaid täiesti eraldi teema. Kas ikka õige koodi all see küs?</i>	b1303	Himu
6.	Mil määral esineb probleeme seoses lootusetuse, jõuetuse või motivatsiooni puudumisega?	Kas on väljendanud abituse või lootusetuse tunnet? Kas arvab, et tal puudub kontroll oma elu üle? Kas on väljendanud suitsiidimõtteid? Kas on teinud suitsiidkatseid?	b1301	Motivatsioon

2.Kas inimese elukeskkond ja sotsiaalne võrgustik on turvalised?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused
1.	Kas inimene tunneb hirmu pereliikme, abistaja või tegevusjuhendaja ees?	Kas tunneb hirmu pereliikme või hooldaja ees? Kas pereliige või hooldaja on käitunud ähvardavalt, alandavalt, hirmutavalt?
2.	Kas inimest koheldakse alavääristavalt?	Kas pereliige või hooldaja käitub inimesega alavääristavalt, halvustavalt? Kas inimest koheldakse lapsena, ehkki ta on otsustusvõimeline? Kas kõike inimese poolt öeldut püütakse alavääristada või maha teha? Kas inimesega käitutakse ülemäära kontrollivalt (ei lasta iseseisvalt otsustada, nt ei lasta tal hindajaga vabalt ja personaalselt rääkida, sekkutakse ja korrigeeritakse pidevalt inimese poolt öeldut)?
3.	Kas inimese suhtes kasutatakse füüsilist vägivalda?	Kas inimese suhtes käitutakse agressiivselt või ähvardavalt? Kas inimesel on märgata füüsilise vägivalla tunnuseid (nt verevalumeid, sinikaid)? Kas teadaolevalt on esinenud seksuaalset ärakasutamist?
4.	Kas inimese suhtes kasutatakse psüühilist vägivalda?	Kas on emotsionaalselt haavatav? Kas tunneb end ebaolulise, rumala või inetuna? Kas tunneb enda pärast piinlikkust?
5.	Kas inimese suhtes kasutatakse majanduslikku vägivalda?	Kas esineb inimese raha või vara väärkasutamist? Kas inimesele piiratakse juurdepääsu tema rahalistele vahenditele?
6.	Kas inimese võimalust vabalt liikuda piiratakse?	Kas inimesele piiratakse juurdepääsu teatud ruumidele tema kodus (nt köök)? Kas piiratakse inimese liikumist väljaspool kodu? Kas inimesele keelatakse abivahendeid, mis võimaldaksid liikumist?
7.	Kas esineb mõni muu risk, mis muudab inimese elukeskkonna ebaturvaliseks?	Kas esineb muid riske, mis võivad inimese elukeskkonna muuta ebaturvaliseks?

Valdkond 3: FÜÜSILINE TERVIS

Tervise eest hoolitsemine

1.Kas inimene suudab iseseisvalt hoolitseda oma füüsilise tervise eest ja kasutada tervishoiuteenused?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleeme oma tervise eest hoidmisel, haigestumise korral abi otsimisel ja arsti nõuannete järgimisel?	Kas inimesel esineb somaatilisi (sh kroonilisi, allergilisi jms) haigusi? Kui jah, siis milles need probleemid seisnevad (nt liigub ratastoolis; üks kehapool halvatud, värinad; vaegnägija vm)? Kui tihti tuleb ette haigestumisi? Kas oskab ja tahab võimaluste piires haigusi/haigestumisi vältida/ennetada? Kas alustab enda ravimisega/tervise parandamisega kohe haiguse avaldumisel või laseb sellel edasi areneda? Kas järgib arstide jt spetsialistide soovitusi (nt füsioterapeudi soovitatud harjutused, päevarežiim vm)? Kas oskab/julgeb/suudab küsida abi, kui tal kusagilt valutab?	d5702	Oma tervise hoidmine
2.	Mil määral esineb probleeme iseenda eest hoolitsemisel, toitumisel ja hea füüsilise vormi säilitamisel?	Kas järgib arstide jt spetsialistide soovitusi või juhiseid tervislike eluviiside osas (dieet, jalutuskäigud, trenn vm)? Kas on motiveeritud oma tervise parandamise/säilitamise nimel vaeva nägema?	d5701	Tervisliku toitumise järgimine ja hea füüsilise vormi eest hoolitsemine
3.	Mil määral esineb probleeme oma füüsilise mugavuse, sh mugava asendi, sobiva valguse ja temperatuuri, tagamisel?	Kas on motiveeritud oma füüsilise heaolu nimel vaeva nägema või tegutsema (nt tuba kütma, tuulutama, lambi valgelt lugema vm)?	d5700	Oma füüsilise mugavuse tagamine

Liikumine

1.Kas inimene suudab iseseisvalt liikuda eluruumides (siseruumides, tuttavates kohtades, kodus)?

4.	Mil määral esineb probleem oma kodus kõndimisel ja liikumisel?	Kas inimene liigub kodus abivahendiga või ilma? Kas inimene vajab kodus ringiliikumiseks abistajat? Kas inimese liikumine oma kodu piires on vaba ja ohutu? Kas abivahendid kompenseerivad liikumispiirangu? Kas inimene pääseb oma kodus liikuma kõikidesse ruumidesse?	d4600	Kodus liikumine
5.	Mil määral esineb probleem ühest asendist teise liikumisel, nt toolile istumisel või istumast püstitõusmisel, pikali heitmisel või pikali asendist püstitõusmisel?	Kas suudab ise oma asendit muuta (tõusta lamamast istuma või toolilt püsti seisma, minna seismisasendist tagasi istuma või voodisse pikali)? Kas suudab kukkudes ise üles tõusta?	d410	Keha põhiasendi muutmine
6.	Mil määral esineb probleem liikumisega seotud tasakaalukaotuse ja kukumisriskiga?	Kas esineb tasakaaluhäireid? Millistel tegevustel on suurim oht tasakaalukaotuseks ja kukumiseks?	b2352	Liikumisega seotud tasakaaluelundi funktsioonid

2.Kas inimene suudab iseseisvalt liikuda väljaspool eluruume (sh füüsiline liikumine, transpordi planeerimine, transpordi kasutamine, abivahendite vajadus – nt trepironija)?

7.	Mil määral esineb probleem väljaspool kodu ilma abivahendita jalgsi liikumisel, sh treppidest käimisel ja väiksemate takistuste (nt äärekivide) ületamisel?	Kas liigub iseseisvalt väljaspool kodu? Kas vajab/kasutab väljaspool kodu liikumiseks abistajat? Kas vajab/ kasutab väljaspool kodu liikumiseks abivahendit? Kui pikki vahemaid on inimene suuteline järjest kõndima? Kas õues liikumine on inimese jaoks ohutu?	d4602	Õues liikumine
----	---	--	-------	----------------

8.	Mil määral esineb probleem hõlbustava vahendiga (nt ratastool, kõnniraam) liikumisel?	Kas saab hakkama/oskab abivahendit õigesti kasutada? Kas abivahend on piisav liikumise hõlbustamiseks?	d465	Vahendiga liikumine
9.	Mil määral esineb probleem reisijana transpordi kasutamisel?	Kas oskab iseseisvalt ühistransporti kasutada? Kas on võimeline tellima nt taksot või sotsiaaltranspordi, et jõuda avalike teenusteni?	d470	Transpordi kasutamine
10.	Mil määral esineb probleem sõiduki (auto, jalgratas) juhtimisel?	Kas sõidab jalgrattaga vm vahendiga? Kas oskab ohutult juhtida sõiduauto vm liikumisvahendit? Kas sõiduki juhtimisel on hiljuti ette tulnud ohtlikke olukordi või liiklusõnnetusi? Kas sõidukijuhtimiseks vajalik tervisetõend on kehtiv?	d475	Sõiduki juhtimine

Valdkond 4: ELUKESKKOND

Sobiva eluaseme saamine/säilitamine

1.Kas inimene on võimeline iseseisvalt olemasolevat eluaset säilitama või uut sobivat eluaset otsime/taotlema?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem eluaseme ostmisel/üürimisel, sisustamisel ja kordaseadmisel?	Kas inimene saab iseseisvalt hakkama endale sobiva eluaseme otsimise ning sellega seotud tehingute (üürimine või ostmine) tegemisega? Kas inimene saab iseseisvalt hakkama eluasemega seotud teenuste ostmise ja lepingute vormistamise ning arvete maksmisega (nt elekter, vesi, küte)? Kas inimene saab iseseisvalt hakkama vajaliku mööbli ja kodutehnika hankimisega?	d610	Eluasemega seotud toimingute tegemine
2.	Mil määral esineb probleem oma vara hooldamisel ja	Kas inimese kodu ja selle sisustus on korralik/töökorras ja puhas? Kas inimene on võimeline oma kodu, selle sisustuse, oma riiete, sõidukite, taimede ja koduloomade eest hoolitsema (sh tellima selleks teenust)?	d650	Koduse vara hooldamine

	koduloomade eest hoolitsemisel?			
--	---------------------------------	--	--	--

Eluase ja elamistingimused

1.Kas inimesel on olemas sobiv elamispind?

JAH/EI vastus

2.Kas inimesel on olemas võimalus abi kutsumiseks?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem olemasolevate sidevahendite kasutamisel?	Kas oskab kasutada telefoni (nutitelefon või nuppudega tel)? Kas oskab kasutada arvutit? Kas kasutab arvutis internetti? Kas oskab kasutada häirenuppu?	d3600	Sidevahendite kasutamine

Valdkond 5: HÕIVATUS

Rakenduse leidmine ja säilitamine

1.Kas inimene on võimeline iseseisvalt leidma või säilitama töö, õppimise vm hõivega seotud rakendust (sh vabatahtlik töö, rakendus kogukonnas)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem hariduse (sh mitteformaalne õppimine) omandamisel ja õppimisega seotud kohustuste täitmisel?	Kus on õppinud ja kui kaua? Kuidas tuli õppimisega toime? Millistes õppeainetes oli tugev/nõrk? Millised õppeained meeldisid?	d839	Õppimine ja hariduse omandamine, täpsustamata

2.	Mil määral esineb probleem töö otsimisel, töökoha säilitamisel, tööalase karjääri tegemisel või töösuhte lõpetamisel?	Milliseid töid on varem teinud ja kus? Kui kaua on töötanud? Kui kaua on ühel töökohal järjest töötanud? Milline on suhtumine töösse? Millised on töösused? Kas on olemas tööharjumus? Milliseid töid suudab teha? Milliseid töid soovib teha (nt käsitöö, füüsiline töö jne)? Kui kaua on võimeline järjest töötama, milline on püsivus?	d845	Töökoha saamine, säilitamine ja töösuhte lõpetamine
----	---	--	------	---

Seotus hõivega

1.Kas inimene on töö, õppimise või muu hõivega seotud?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem täistööajaga töötamisel?	Kas on tahe ja suutlikkus teha täiskoormusega tööd? Kas vajab toetust täiskoormusega töötamisel? Mis laadi toetust vajab (nt kindlustunde tagamine, juhendamine)?	d8502	Täistööajaga töötamine
2.	Mil määral esineb probleem osatööajaga töötamisel?	Kas töötab osalise koormusega? Miks töötab osalise koormusega? Kas vajab toetust osalise koormusega töötamisel? Mis laadi toetust vajab?	d8501	Osatööajaga töötamine
3.	Mil määral esineb probleem eraettevõtlusega tegelemisel?	Kas töötab iseseisvalt? Kas on võimeline ise oma tööd juhtima ja organiseerima? Kas tuleb toime ettevõtte juhtimisega kaasneva vastutuse, töökoormuse ja aruandlusega?	d8500	Eraettevõtlusega tegelemine
4.	Mil määral esineb probleem koolihariduse omandamisel (põhi- ja keskkharidus)?	Kas inimene on omandanud põhi- või keskkhariduse? Kas põhihariduse omandamisel esines raskusi (nt jäi klassi kordama)?	d820	Koolihariduse omandamine (põhi- ja keskkharidus)

		Kas keskhariduse omandamisel esines takistusi, raskusi?		
5.	Mil määral esineb probleem kutsehariduse omandamisel?	Kas inimene on omandanud kutsehariduse? Millisel erialal? Kas kutsehariduse omandamisel esines takistusi, raskusi? Kas töötab omandatud erialal?	d825	Kutsehariduse omandamine
6.	Mil määral esineb probleem kõrghariduse omandamisel?	Kas inimene on omandanud kõrghariduse? Millisel erialal? Kas kõrghariduse omandamisel esines takistusi, raskusi? Kas töötab omandatud erialal?	d830	Kõrghariduse omandamine
7.	Mil määral esineb probleem täiendõppes või tööpraktikal osalemisel?	Kas inimene on osalenud täiendõppes või mõnel tööpraktikal? Kas täiendõppe või tööpraktika läbimisel esines takistusi, raskusi? Kas täiendõppe või tööpraktika läbimine võimaldas leida sobiva töö?	d840	Täiendusõppes või tööpraktikal osalemine

Sissetuleku säilimine

1.Kas inimese töötasu või muu sissetulek on püsinud muutumatu sõltumata tervislikust olukorrast?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem majandusliku turvalisuse tagamisel ja inimese vajaduste rahuldamisel?	Kas inimesel on piisavalt sissetulekuid või rahalisi vahendeid, et oma igapäevased vajadused rahuldada? Kas inimene sõltub oma rahalises toimetulekus kellestki teisest? Kas terviseolukorra halvenemine on kaasa toonud sissetulekute vähenemise?	d870	Majanduslikult sõltumatu olemine

Valdkond 6: VABA AEG JA HUVITEGEVUS

Vaba aeg

1.Kas inimene suudab iseseisvalt oma vaba aega sisustada, leida või säilitada huvitegevuse võimalusi (sh puhkuse ja tööhõive vahelise tasakaalu hoidmine)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem hobidega (nt lugemine, reisimine, käsitöö, sport jm) tegelemisel ja vabaajategevustest (nt kino, teater, muuseum jm) osavõtmisel?	Milliste huvitegevuste ja hobidega on varem tegelenud? Millised on vaba aja veetmise eelistused? Millised on vabaaja veetmise oskused (nt. rahvatantsuoskus, oskab mängida suupilli, kepikõnd, fotograafia, käsitöö jne)?	d920	Puhke- ja vabaaja tegevustes osalemine
2.	Mil määral esineb probleem kogukondlikus seltskonnaelus osalemisel?	Kas osaleb kogukondlikes tegevustes (huviringid, päevakeskused, ühised väljasõidud jm ühistevõrgud)? Kas saab/tahab kogukonna või seltskonna üritustel osaleda? Kas on sõpruskond, kellega kohtuda ja ühiselt aega veeta?	d910	Kogukonnaelus osalemine

Valdkond 7: IGAPÄEVAELU TOIMINGUD

Rahadega toimetulek

1.Kas inimene on iseseisev oma rahade planeerimisel ning asjaajamisel (sh eelarve planeerimine, rahaliste vahenditega toimetulek, pangateenuste kasutamine, arvete tasumine, suhtlus ametiasutuste ja erinevate teenuseosutajatega)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem igapäevaeluks	Kas tuleb iseseisvalt toime erinevate nii toidu- ja kui tööstuskaupade hankimisega?	d620	Kaupade ja teenuste soetamine

	vajalike ostude tegemisel ja teenuste tellimisel?	Kas saab hakkama erinevate teenuste tellimisega (nt elektritööd, prügivedu vms)/teenustel käimisega (nt juuksur)?		
2.	Mil määral esineb probleem raha kasutamisel ja säästmisel või võlgade tasumisel?	Kas tunneb raha väärtust? Kas suudab eelarvet planeerida ja järgida? Kui vajab abi, siis milles abivajadus seisneb? Kas on võlgnevusi, millega on vaja tegeleda?	d860	Lihtsate majandustegevuste sooritamine
3.	Mil määral esineb probleem pangakonto pidamisel ja pangateenuste kasutamisel?	Millised on kogemused ja oskused pangas käimisega? Kas kasutab pangakaarti (kas oskab/suudab sisestada PIN-koodi)? Kas vajad abi pangakonto haldamisel või pangateenuste kasutamisel?	d865	Keeruliste majandustegevuste sooritamine

Toidu valmistamine

1.Kas inimene suudab iseseisvalt süüa valmistada ja teha sellega seotud tegevusi (sh toidu hankimine poest, toidu valmistamine, toidu soojendamise)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem igapäevaste toidu- ja tööstuskaupade ostmisel?	Kas on võimeline ette mõtlema, mida söögiks valmistada ja mida selleks poest on vaja osta? Kas ta on võimeline poest toiduaineid ostma, nt ettevalmistatud nimekirjaga? Kas poest vajalike toiduainete soetamisel (sh koju toomisel) esineb raskusi/takistusi?	d6200	Sisseostude tegemine
2.	Mil määral esineb probleem nii kuuma kui külma toidu valmistamisel ja serveerimisel?	Kas oskab endale lihtsamaid toite valmistada (nt võileiba, pastat, putru, praemuna vmt)? Kas inimene oskab endale keerulisemaid toite (nt suppe, ahjuroogasid, kooke vms) valmistada? Kas iniene oskab olemasolevat valmistoitu soojendada?	d630	Toidu valmistamine

		Kas on olemas oskused toidu tükeldamiseks ja taldrikule tõstmiseks? Kui mitte, siis mis takistab (nt halb tasakaal, värisemine vm)? Kas oskab katta laua?		
3.	Mil määral esineb probleem köögi korrastamisel peale söögitegemist, toiduvalmistamiskoha pindade puhastamisel ja nõude pesemisel?	Kas oskab/suudab pärast toiduvalmistamist koristada laua, puhastada töötasapinnad? Kas oskab/suudab pärast toiduvalmistamist pesta kasutatud nõud? Kas oskab panna nõud nõudepesumasinasse? Kas hoiab köögis puhtust?	d6401	Köögi koristamine ja nõude pesemine

Söömine ja joomine

1.Kas inimene suudab iseseisvalt süüa-juua ja teha sellega seotud tegevusi (sh toidu või joogi tõstmine taldrikule/valamine tassi, noa, kahvli, lusika kasutamine, toidu tükeldamine)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem söögiriistade kasutamisel (sh purkide-konservide avamisel), toidu tükeldamisel ja söömisel?	Kas sööb iseseisvalt või vajab abistamist/söötmist? Kas oskab söömisel kasutada nuga-kahvli? Kas vajab kohandatud toidunõusid? Milline on söömiskultuur, nt sööb kiirustades, kugistab, neelab suuri tükke? Kas vajab tükeldatud või püreestatud toitu? Kas vajab erimenüüd? Kas peab sööma teistest eraldi? Kui jah, siis mis põhjusel?	d550	Söömine
2.	Mil määral esineb probleem pudelite vm jooginõude avamisel, joogi segamisel ja valamisel, (kõrrega) joomisel?	Kuidas tuleb toime tassist/klaasist/pudelist joomisega? Kas suudab kallata jooki pudelist/ kannust klaasi? Kas joob piisavalt vedelikku? Kas joob liiga palju kanget teed või -kohvi või karastusjooke?	d560	Joomine

Majapidamine

1.Kas inimene suudab iseseisvalt teha majapidamisega seotud tegevusi (sh koristamine, pesu pesemine, kodumasinade kasutamine jm elukoha eest hoolitsemisega seotud toimingud)?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem eluruumide koristamisel, sh tolmu võtmisel, põrandate puhastamisel, akende pesemisel, kardinade vahetamisel, vannitoa ja WC koristamisel?	Kas osaleb igapäevaste koduste tööde tegemises? Milliseid kodutöid teeb vabatahtlikult ja hea meelega? Milliste kodutööde tegemisel vajab toetust? Kas vajab kodutööde tegemisel juhendamist/suunamist/motiveerimist? Kas saab ise aru, millal on vaja koristada?	d6402	Eluruumide koristamine
2.	Mil määral esineb probleem pesu pesemisel ja kuivama riputamisel?	Kas oskab/tahab jälgida oma riiete puhtust ja vajadusel neid pesta? Kas oskab kasutada pesumasinat? Kas oskab/saab hakkama pesuvahendi doseerimisega? Kas saab iseseisvalt hakkama pesu kuivama riputamise?	d6400	Riiete ja pesu pesemine ja kuivatamine
3.	Mil määral esineb probleem kodumasinade, nt pesumasin, triikraud, tolmuimeja, nõudepesumasin, kasutamisel?	Kas oskab kasutada nn tubaseid kodumasinaid (nt. pesumasin, triikraud, tolmuimeja, veekeetja jne)? Kas oskab/suudab vajadusel käsitseda õues kasutatavaid masinaid (nt. muruniiduk, traktor jm)?	d6403	Kodutehnika kasutamine
4.	Mil määral esineb probleem prügi sorteerimisel ja sobivasse prügikonteinerisse viskamisel?	Kas saab hakkama lihtsama prügisorteerimisega (nt eraldada paberjätmed pakendist või biojätmetest)? Kas on valmis vabanema endale mittevajalikest või kasutuskõlbmatutest esemetest? Kas on võimeline viima prügi õues olevasse sobivasse prügikonteinerisse? Kas teab, mida teha üle jäänud või aegunud ravimitega?	d6405	Jätmete kõrvaldamine

5.	Mil määral esineb probleem kõnni- ja sissepääsuteede korras hoidmisel, nt lume ja lehtede koristamisel ja libedusetõrje tegemisel?	Kas on võimeline hooldama oma eluasemega seotud kõnni- või sissesõiduteed? Kas on võimeline kasutama tee hooldamiseks kasutatavaid tööriistu (nt luud, lumelabidas, reha vms)?	d6507	Kõnni- ja sissesõiduteede eest hoolitsemine
----	--	---	-------	---

Enese eest hoolitsemine

1. Kas inimene on võimeline iseseisvalt teostama enese hooldusega seotud toiminguid (sh enda pesemine, tualeti kasutamine, riietumine kodus ja riietumine välja minemiseks)?

Nr.	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral esineb probleem enda pesemisel ja kuivatamisel, vannis ja duši all käimisel?	Millised on harjumused seoses enesehügieeniga? Kas saab iseseisvalt hakkama oma erinevate kehaosade pesemisega (nt jalad, pea, selg vm)? Milline on toetusvajadus enda pesemisel (nt. tähelepanu juhtimine, meeldetuletamine, suunamine, abistamine)? Kas esineb riske seoses iseseisva pesemisega (kukkumiskriis, põletusohu kuumaga veega vms)?	d510	Enda pesemine
2.	Mil määral esineb probleem tualetitoimingutel ja seejärel enda puhastamisel?	Kas saab iseseisvalt hakkama tualetis käimisega? Kas saab iseseisvalt hakkama enese puhastamisega peale tualetis käimist? Kas kasutab mähkmeid?	d530	Tualetitoimingute tegemine
3.	Mil määral esineb probleem riide selga ja jalanõude jalga panekul ja äravõtmisel, sh ilmastikule sobivate ja sotsiaalset olukorda arvestavate riide või jalanõude valimisel?	Kas paneb riidesse või võtab riidest lahti ise või abiga? Kas saab ise kinni lukud või nööbid? Kas aitab ise riietumisel kaasa (näit. sirutab käe ette vms)? Kas oskab valida riideid vastavalt ilmastikule?	d540	Riietumine

4.	Mil määral esineb probleem hammaste, juuste, küünte ja naha eest hoolitsemisel?	Kas peseb ise hambaid ja oskab doseerida hambapastat? Kas tuleb iseseisvalt toime küünte lõikamisega? Kas tuleb iseseisvalt toime juuste kammimisega, soengusse sättimisega? Kas ajab iseseisvalt habet või vajab abistamist?	d520	Kehaosade hooldamine
----	---	--	------	----------------------

MITTEAMETLIK ABI

Abi perekonnalt

1.Kas perekond aitab?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut perekond, sh abikaasa, elukaaslased, vanemad, õed-vennad, lapsed, vanavanemad?	Kas on võimalik igapäevaselt kasutada pereliikmete abi? Kas pereliikmete abiga saab inimene kõigi oma igapäevaste tegevustega hakkama? Milline on tema abistamisega seotud hoolduskoormus pereliikmetele (suur, keskmine väike)? Kas keegi pereliikmetest on selleks, et teda igapäevaselt aidata, pidanud loobuma töölkäimisest?	e310	Perekond
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut laiendatud perekond, sh tädid-onud, õe-/vennalapsed?	Kas on võimalik igapäevaselt kasutada sugulaste abi? Kas sugulaste abiga saab inimene kõigi oma igapäevaste tegevustega hakkama?	e315	Laiendatud perekond

Abi sõpradelt ja tuttaval

1.Kas sõbrad ja tuttavad abistavad?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
----	---------	---------------------	------	---------

1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut sõbrad?	Kas on võimalik igapäevaselt kasutada sõprade abi? Kas sõprade abiga saab inimene kõigi oma igapäevaste tegevustega hakkama?	e320	Sõbrad
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut tuttavad, eakaaslased, kolleegid, naabrid, kogukonna liikmed?	Kas on võimalik igapäevaselt kasutada tuttavate, naabrite, kolleegide vms abi? Kas tuttavate abiga saab inimene kõigi oma igapäevaste tegevustega hakkama?	e325	Tuttavad, eakaaslased, kolleegid, naabrid ja kogukonnaliikmed
3.	Mil määral mõjutavad toimetulekut koduloomad, sh lemmikloomad, liikumisel abistavad loomad (nt pimedajuhtkoer)?	Kas kasutab toimetulekuks kodustatud looma (nt juhtkoera) abi? Kas kodustatud looma abiga saab inimene oma igapäevaste tegevustega hakkama?	e350	Kodustatud loomad

AMETLIK ABI, TOETUSED JA TEENUSED

Sotsiaalvaldkonna teenused

1.Kas abi on korraldatud riikliku või kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande teenustega?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut ametlikud abistajad (tugiisikud, hooldajad, tegevusjuhendajad jt)?	Kas kasutab toimetulekuks tugiisiku või hooldaja abi? Kas tugiisiku või hooldaja abiga saab inimene oma igapäevaste tegevustega hakkama?	e340	Tugiisikud ja hooldajad
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut üldised sotsiaalhoolekandeteenused, sh igapäevaelu toetavad teenused, erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenused, sotsiaaltransport?	Kas kasutab toimetulekuks sotsiaalhoolekandeteenuseid? Kui jah, siis milliseid ja kui kaua? Kas sotsiaalhoolekandeteenuste abiga tuleb inimene oma igapäevaste tegevustega toime?	e5750	Üldised sotsiaalhoolekandeteenused

3.	Mil määral mõjutavad toimetulekut rahalised hüvitised, sh vanemahüvitis, vajadustel põhinevad toetused (nt toimetulekutoetus), puuetega inimese toetused, pensionid?	Kas kasutab toimetulekuks sotsiaalkaitseteenuseid? Kui jah, siis milliseid? Kas sotsiaalkaitseteenuste abiga tuleb inimene oma igapäevaste tegevustega toime?	e5700	Sotsiaalkaitseteenused
4.	Mil määral mõjutavad toimetulekut eluruumi tagamise teenused, sh varjupaik, sotsiaaleluruum, teenusmaja?	Kas kasutab toimetulekuks elamumajandusteenuseid? Kas elamumajandusteenuste abiga tuleb inimene oma elukorraldusega toime?	e5250	Elamumajandusteenused

Tervishoiuvaldkonna teenused

1.Kas abi on korraldatud tervisevaldkonna teenustega?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut ravimid?	Kas kasutab igapäevaselt ravimeid? Mil määral sõltub inimese toimetulek ravimitest?	e1101	Ravimid
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut tervishoiuteenused, sh esmaabi, akuutravi, taastus- ja hooldusravi?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad tervishoiuteenused? Mil määral sõltub inimese toimetulek tervishoiuteenustest?	e5800	Tervishoiuteenused
3.	Mil määral mõjutavad toimetulekut tervisevaldkonna töötajad?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad tervishoiu(valdkonna) töötajad? Mil määral sõltub inimese toimetulek tervishoiu(valdkonna) töötajatest?	e355	Tervishoiuvaldkonna töötajad

Tööhõive valdkonna teenused

1.Kas abi on korraldatud tööhõive valdkonna teenustega?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut tööturuteenused, sh abi töö otsimisel, karjäärinõustamine, tööturukoolitused, tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad töö- ja tööturuteenused? Mil määral sõltub toimetulek töö- ja tööturuteenustest?	e5900	Töö- ja tööturuteenused

Haridusvaldkonna teenused**1.Kas abi on korraldatud haridusvaldkonna teenustega?**

Nr.	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut haridusteenused erinevatel haridustasanditel, sh täiskasvanute täienduskoolitused ja elukestva õppe programmid?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad haridusteenused? Mil määral sõltub toimetulek haridusteenustest?	e5850	Haridusteenused

Muud teenused**1.Kas abi on korraldatud abi muude valdkondade teenustega?**

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut inimesed, kellel on vastutus teha otsuseid, nt eestkostja?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad isikud, kelle otsustest inimene sõltub? Mil määral sõltub toimetulek juhtpositsiooniga inimestest (nt eestkostja)?	e330	Juhtpositsiooniga inimesed

2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut muude erialade inimesed ja teenuseosutajad, kes inimesele abi osutavad?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad muude erialade inimesed? Mil määral sõltub toimetulek muude erialade inimestest (nt tugiisikust, õpetajast, sotsiaaltöötajast)?	e360	Muude erialade inimesed

ABIVAHENDID JA ESEMELINE ABI

Abivahendid

1.Kas inimene kasutab abivahendeid?

Nr	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut abivahendid igapäevaseks isiklikuks kasutamiseks, sh proteesid ja ortoosid, põie ja soole kontrollimise vahendid, hingamistegevuse ja südametöö kontrollimise vahendid?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad isiklikud abivahendid (nt proteesid, ortoosid, hingamis- või südametöö kontrollimise vahendid vm)? Mil määral sõltub toimetulek isiklikest abivahenditest?	e1151	Abivahendid ja -tehnoloogiad igapäevaseks isiklikuks kasutamiseks
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut liikumisabivahendid, sh käimisabivahendid, kohandatud sõidukid, ratastoolid, siirdumise abivahendid?	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad liikumisabivahendid? Mil määral sõltub toimetulek liikumisabivahenditest?	e1201	Abivahendid ja tehnoloogiad inimese liikumiseks ning transpordiks siseruumides ja väljas
3.	Mil määral mõjutavad toimetulekut suhtlemist toetavad abivahendid, sh nägemis- ja kuulmisabivahendid (nt prillid, kuuldeaparaat, alternatiivsed	Kas iseseisvat toimetulekut mõjutavad nägemis- ja kuulmisabivahendid? Mil määral sõltub toimetulek nägemis- ja kuulmisabivahenditest?	e1251	Suhtlus- ja teabevahetus abivahendid ja tehnoloogiad

	kommunikatsioonivahendid nagu piktogrammid v viipekeel), spetsiaalne arvuti riist- ja tarkvara?			
--	---	--	--	--

Eluruumi kohandused

1.Kas inimese eluruum on kohandatud tema abivajadust silmas pidades?

Nr.	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut eluaseme kohandatud sisse- ja väljapääsud, sh automaatselt avanevad ukse, käsipuud, kohandatud ukseligid, madaldusega lävepakud, kaldteed?	Kas inimene vajab iseseisvaks liikumiseks oma eluaseme sisse- ja väljapääsude kohandamist? Mil määral sõltub iseseisev toimetulek eluaseme sisse- ja väljapääsude kohandamisest?	e1550	Eravaldues olevate hoonete sisse- ja väljapääsude kujundus, konstruktsioon, ehitusmaterjalid ja tehnoloogiad
2.	Mil määral mõjutavad toimetulekut eluaseme kohandatud siseruumid, sh vannitoa sisustus, seadmed ja elektrilised kontrollmehhanismid?	Kas vajab iseseisvaks liikumiseks siseruumides elukoha kohandamist? Mil määral sõltub iseseisev toimetulek elukoha siseruumide kohandamisest?	e1551	Eravaldues olevate hoonete siseruumidele juurdepääsu võimaldav kujundus, konstruktsioon, ehitusmaterjalid ja tehnoloogiad
3.	Mil määral mõjutavad toimetulekut suhtlus- ja teabevahendid, sh telefon või häirenupp?	Kas on olemas võimalus abi kutsumiseks (telefon, arvuti vm sidevahend)? Kas oskab abi kutsumiseks sidevahendeid kasutada? Kas vajab häirenupu teenust?	e1250	Suhtlus- ja teabevahetus tavavahendid ja tehnoloogia

Varad ja rahalised vahendid

1.Kas inimesel on kasutada piisavalt vahendeid oma toimetuleku toetamiseks?

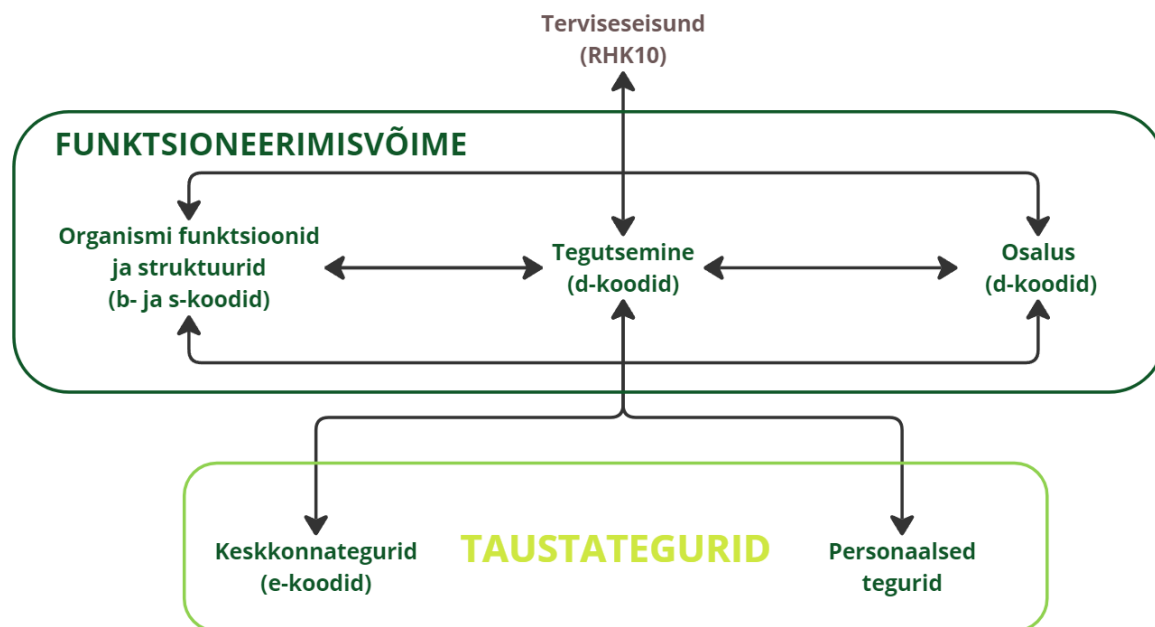
Nr .	Küsimus	Abistavad küsimused	Kood	Nimetus
1.	Mil määral mõjutavad toimetulekut rahalised vahendid?	Kas on piisavalt rahalisi vahendeid, et rahuldada oma igapäevased primaarsed vajadused? Mil määral on rahaliste vahendite nappus mõjutanud igapäevast toimetulekut?	e1650	Rahalised vahendid
2.	Mil määral mõjutab toimetulekut materiaalne vara?	Kas on isiklikku materiaalet vara? Mil määral on materiaalse vara puudumine mõjutanud igapäevast toimetulekut?	e1651	Materiaalne vara

LISA 2. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni põhimõtted

Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon (RFK) on koostatud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt 2001. aastal ja kuulub koos RHK10-ga WHO rahvusvaheliste klassifikatsioonide perekonda. RFK on terviklik raamistik tervise ja tervisega seotud seisundite ning vajaduste dokumenteerimiseks, mille eesmärgiks on paremini mõista, kuidas terviseseisund mõjutab inimese toimetulekut. Kasutades funktsioneerimisvõimega seotud info dokumenteerimiseks RFK-d, muudab see inimese kohta kogutud andmed võrreldavaks erinevate erialade ja valdkondade vahel, samuti erinevate ajaperioodide lõikes ning ka rahvusvahelisel tasandil.

Funktsioneerimisvõime tähendab inimese füüsilist, psühholoogilist ja sotsiaalset võimekust tulla toime oma elukeskkonnas igapäevaste tegevuste ja olukordadega, mis on talle tähenduslikud (nt töö, õpingud, vaba aeg ja hobid, enese ja teiste eest hoolitsemine). Funktsioneerimisvõime langus ei ole alati haiguse tagajärg, vaid sõltub erinevatest teguritest (füüsiline keskkond, sotsiaalsed suhted) ning üht ja sama haigust põdevate inimeste võime toime tulla on väga erinev. Funktsioneerimine võib ühe ja sama inimese puhul ajas muutuda, kuigi diagnoos ei muutu.

Klassifikatsioon koosneb kahest osast: **funktsioneerimisvõime ja taustategurid** (vt Joonis 1). Funktsioneerimisvõime alla kuuluvad 1) organismi funktsioonid (b-koodid) ja struktuurid (s-koodid) ning 2) tegutsemine ja osalus (d-koodid). Taustategurite alla kuuluvad 3) keskkonnategurid (e-koodid) ja personaalsed tegurid.



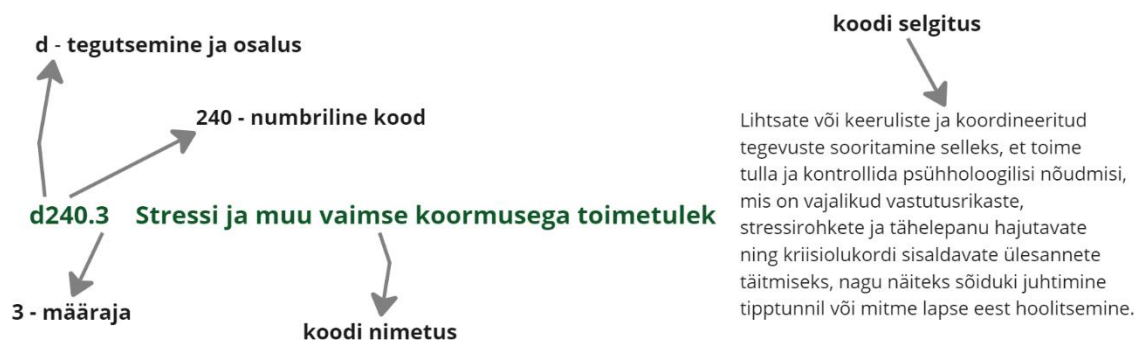
Joonis 1. Klassifikatsiooni ülesehitus

Organismi **funktsioonid** on elundsüsteemide füsioloogilised talitused, kaasa arvatud psüühilised funktsioonid (nt südame funktsioonid, emotsioonide funktsioonid, mälufunktsioonid). Organismi **struktuurid** on keha anatoomilised osad, elundid, jäsemed või nende osad (nt südame-veresoonkonna struktuur, närvisüsteemi struktuur, nina struktuur). **Tegutsemine** on ülesande täitmine või tegevuse sooritamine ja **osalus** on inimese kaasatus elulisse situatsiooni (nt söömine, enda pesemine, kodutööde tegemine, kogukonnaelus osalemine).

Keskkonnategurid moodustavad füüsilise, sotsiaalse ja suhtumusliku keskkonna, milles inimene elab ja mis võivad inimese funktsioneerimisvõimet nii takistada kui hõlbustada (nt elukeskkond, rahalised vahendid, töövahendid ja –tehnoloogiad, ravimid). **Personaalsed tegurid** on vanus, sugu, sotsiaalne seisund, elukogemused jne. Viimaseid eraldiseisvalt ei klassifitseerita ja koodid puuduvad.

RFK kood koosneb eesliitest (täht: b, s, d ja e), numbrilisest koodist ja määrajast (0-4, 8,9). Eesliite täht näitab jagu ja kohta klassifikatsioonis. RFK kood koosneb kolmest kuni viiest numbrist. Esimene number näitab peatükki.

Näiteks d240 stressi ja muu vaimse koormusega toimetulek (vt Joonis 2) kuulub peatüki d2 “Üldised ülesanded ja nõuded” alla, mis käsitleb ühe või mitme ülesande teostamise, rutiinide loomise ja stressiga toimetuleku üldiseid aspekte. Täisealise abivajaduse hindamisvahendis valdkonna “Vaimne tervis” psüühilise seisundi all on kood d240 seotud küsimusega “Täpsusta, millisel määral esineb probleem tegevuste sooritamisel stressirohketes ja vastutusrikastes olukordades.” Sotsiaalvaldkonna spetsialistil tuleb selle küsimuse juures märkida, kuidas inimene ise hindab oma toimetulekut stressiga.



Joonis 2. RFK koodi ülesehitus klassifikatsioonis

Täisealise abivajaduse hindamisvahendis on kasutusel organismi funktsioone (b), tegutsemist ja osalust (d) ning keskkonnategureid (e) kirjeldavad koodid. Koodid on seotud eluvaldkonnapõhise hindamismetoodika küsimustega ning hindamist läbiviiv spetsialist ei pea ise RFK koodi klassifikatsioonist valima.

Hindamisel on oluline valida **määraja** ehk raskusaste, mis kõige paremini kirjeldab hinnatava inimese tegevusvõimet, võttes arvesse tema sooritust **koos abistaja, abivahendite, ravimite** ja muude kompenseerivate meetoditega. Oluline on meele pidada, et need peavad inimese jaoks ka igapäevaselt kättesaadavad olema. Lisaks on oluline probleemi tuvastamisel iga küsimuse ja määraja juurde **täiendada ka lahtrit “Lisa kommentaar”**, et määraja valikut selgitada ning andmete vahetamise vaates tagada terviklik info hinnatava inimese kohta.

The screenshot shows a web-based assessment interface. At the top, there are two labels: 'RFK koodi nimetus' (RFK code name) and 'RFK kood' (RFK code). Below them, the code name is 'Stressi ja muu vaimse koormusega toimetulek (d240)' and the code is 'd240'. The main part of the interface is a horizontal scale with five buttons: '0 Ei ole', '1 Kerge', '2 Mõõdukas', '3 Raske', and '4 Täielik'. The '4 Täielik' button is highlighted in red. Below the scale, there is a text box with a description in Estonian: 'Inimese enda hinnangul ei suuda ta toime tulla vaimse koormusega, mida hiljutine töökaotus ning pikaaegse suhte lõppemine kaasa on toonud. Igapäevategevustega ei ole suuteline tegelema, voodist tõuseb ainult selleks, et tualetti minna. Ravimeid pole siiani tarvitanud ning psühholoogilisele nõustamisele ei ole veel jõudnud.' At the bottom right of the text box are two buttons: 'Muuda' (Change) and 'Kustuta' (Delete).

Joonis 4. RFK koodi, koodi nimetuse ja määraja asukoht STAR2 hindamisvahendis.

Sobiva määraja valimine. Määraja tähistab piirangu olulisust ehk kahjustuse ulatust või probleemi tõsidust. Määrajat on võimalik valida skaalal 0-4 ning lisaks on määrajad 8 (täpsustamata) ja 9 (mittekohaldatav). Viimast kahte on võimalik valida juhul, kui ei ole võimalik raskusastet selgelt tuvastada.

Määrajate skaala kasutamine piirangute tuvastamiseks RFK koodi d550 söömine näitel (Tabel 4).

Kood on hindamisvahendis seostatud valdkonna “Igapäevaelu toimingud” all küsimusega “Täpsusta, millisel määral esineb probleem söögiriistade kasutamisel (sh purkide-konservide avamisel), toidu tükeldamisel ja söömisel.”

Tabel 4. Määrajate skaala piirangute tuvastamine ühe koodi näitel.

0	EI OLE probleemi (0–4%)	Inimene saab igal söögikorral noa-kahvliga söömisega hakkama
1	KERGE probleem. (5–24%)	Inimesel läheb tavapärasest kauem aega purkide avamise/sulgemisele, kuid söömisel piirangud puuduvad
2	MÕÕDUKAS probleem (25–49%)	Inimene ei suuda ise noaga (liha)tükke väiksemaks lõigata, vajab ettevalmistatud toite, piiratud menüüvalik
3	RASKE probleem (50-95%)	Inimesel puuduvad osaliselt hambad, vajab pehmemaid toite. Kätes pole piisavalt jõudu, et toitu sobivaks tükeldada. Puuduvad abivahendid.
4	TÄIELIK probleem (96–100%)	Inimene ei suuda toitu suhu viia ning söögiriistu kasutada. Abistajat ei ole.
8	täpsustamata (olemasolev informatsioon ei võimalda täpsemalt probleemi raskust tuvastada).	Inimene ütles, et söömisega on probleeme, kuid ei suutnud detailsemalt täpsustada.
9	mittekohaldatav (kood ei ole rakendatav)	„Inimene sõi viimati rohkem kui 30. päeva tagasi, puudub asjakohane ülevaade, millised on tänased söömisega seotud piirangud“

Määrajate 0, 8 ja 9 kasutamisest RFK koodi d465 “Vahendiga liikumise” näitel.

Kood on hindamisvahendis seostatud valdkonna “Füüsiline tervis” all küsimusega: “Täpsusta, millisel määral esineb probleem hõlbustava vahendiga (nt ratastool, kõnniraam) liikumisel”.

Kui inimesel on olemas hõlbustav vahend ning ta saab sellega probleemideta liikuda, siis tuleb valida raskuastmeks “0 Ei ole” ehk probleemi ei esine ja inimene saab hakkama (vt Joonis 5). Kui probleemi ulatust ei ole võimalik hinnata ning inimese või tema lähedase käest ei ole võimalik saada piisavalt infot, kas ta üldse mingit abivahendit kasutab, siis tuleb vastuseks märkida “Täpsustamata” (Joonis 6). Kui inimene ei kasuta liikumiseks ühtegi abivahendit, siis tuleb vastuseks märkida “Mittekohaldatav”. Sama vastusevariant märgitakse ka nendel juhtudel, kui inimesele on abivahend määratud, ta on selle ka välja ostanud või rentinud, kuid mingil põhjusel ikkagi ei kasuta seda.

... hõlbustava vahendiga (nt ratastool, kõnniraam) liikumisel?

Vahendiga liikumine (d465) ⓘ

0 Ei ole

1 Kerge

2 Mõõdukas

3 Raske

4 Täielik

Täpsustamata

Mittekohaldatav

Inimene kasutab liikumiseks spetsiaalset vahendit ja pääseb sellega igale poole probleemideta.

Muuda ✎

Kustuta 🗑

Joonis 5. Ei ole probleemi (määraja 0) kasutamine.

... hõlbustava vahendiga (nt ratastool, kõnniraam) liikumisel?

Vahendiga liikumine (d465) ⓘ

0 Ei ole

1 Kerge

2 Mõõdukas

3 Raske

4 Täielik

Täpsustamata

Mittekohaldatav

Inimese vastusest ei ole võimalik kätte saada infot, kas inimene kasutab liikumisel enamasti mingit spetsiaalset vahendit ja kas see ka vähendab raskusi liikumisel. Piirangu suurust ei ole võimalik hinnata.

Muuda ✎

Kustuta 🗑

Joonis 6. Täpsustamata (määraja 8) kasutamine.

... hõlbustava vahendiga (nt ratastool, kõnniraam) liikumisel?

Vahendiga liikumine (d465) ⓘ

0 Ei ole

1 Kerge

2 Mõõdukas

3 Raske

4 Täielik

Täpsustamata

Mittekohaldatav

Inimene ei kasuta liikumiseks spetsiaalseid vahendeid või varustust.

Muuda ✎

Kustuta 🗑

Joonis 7. Mittekohaldatav (määraja 9) kasutamine.